

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider

Delrapport om överenskommelsen 2025

Innehåll

Inledning	5
Prevention och tidig upptäckt	6
Prevention	6
Särskild satsning för att utrota livmoderhalscancer	7
Tidig upptäckt.....	7
Tidig upptäckt i primärvården	7
Organiserad prostatacancertestning	8
Cancerscreening	9
Tillgänglig och god vård med fokus på patienten.....	12
Standardiserade vårdförlopp	12
Fortsatt arbete med förbättringsprojekt inom bild- och funktionsmedicin och radiologi	13
Min vårdplan	13
Rehabilitering och palliativ vård.....	14
Rehabilitering.....	14
Fortsatt arbete med förbättringsprojekt inom rehabilitering och palliativ vård	15
Palliativ vård	15
Barncancer	16
Kunskapsutveckling samt kompetensförsörjning och forskning	17
Kunskapsutveckling.....	17
Arbete med nationella vårdprogram	17
Arbete med regimbiblioteket	18
Insatser som underlättar uppföljningen av cancervården	18
Kompetensförsörjning och forskning	20
Strålbehandling	20
Comprehensive Cancer Centre	21
Innovation.....	21
Utbildningar	21

Ökad tillgång till kliniska studier.....	22
Tillgång till och användning av medicinska teknologier	23
Precisionsmedicin	23
Stöd för användandet av AI.....	23
Cancergenomik	23

Bilaga 1: Samverkansregionala insatser

Inledning

Överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och staten är ett effektivt verktyg för att driva utvecklingen framåt med utgångspunkt i den nationella cancerstrategin. Ett arbete med revidering av cancerstrategin har pågått under året. Överenskommelsen för 2025 bygger på den strategi som togs fram under 2009. Genom att följa upp arbetet som bedrivs inom ramen för överenskommelserna och årligen revidera insatserna kan utvecklingen drivas framåt på ett snabbt och effektivt sätt. Överenskommelsen för 2025 omfattar totalt 817 miljoner kronor och delas in i fyra områden som motsvarar cancerstrategins delar:

- Prevention och tidig upptäckt
- Tillgänglig och god vård med mera, med fokus på patienten
- Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning
- Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Insatserna ligger väl i linje med EU:s cancerplan.

Insatserna i överenskommelsen genomförs av de regionala cancercentrumen (RCC) tillsammans med regionerna. RCC samarbetar på nationell nivå genom RCC i samverkan som består av cheferna för RCC samt den nationella cancersamordnaren på Sveriges Kommuner och Regioner. RCC i samverkans arbete bedrivs i hög grad genom de nationella arbetsgrupperna. Det finns diagnosspecifika nationella vårdprogramgrupper och kvalitetsregistergrupper samt diagnosövergripande arbetsgrupper för till exempel prevention, cancerläkemedel och rehabilitering.

Genom att arbeta med insatserna på ett nationellt samordnat sätt ökar förutsättningarna för en jämlik cancervård oavsett vem man är och vad man bor i landet.

Delrapporten redovisar de insatser som ingår i 2025 års överenskommelse. Redovisningen följer överenskommelsens struktur och beskriver i korthet hur arbetet med de nationella insatserna har fortskridit. De samverkansregionala insatserna redovisas som bilaga 1.

Prevention och tidig upptäckt

Prevention

Arbetet med cancerprevention har fortskridit i enlighet med canceröverenskommelsen för 2025 samt den nationella cancerpreventionsplanen 2024–2030. Den nationella arbetsgruppen (NAG) cancerprevention har publicerat en [vetenskaplig artikel](#) om allmänhetens kännedom om den europeiska kodexen mot cancer, som en del av European Union's EU4Health programme. Resultaten visar att få personer har hört talas om kodexen men att den motiverar ungefär en tredjedel till att förbättra sina levnadsvanor.

NAG cancerprevention har även arrangerat webinarium i samband med European Week Against Cancer och genomfört en mediasatsning inom ramen för det kunskapshöjande initiativet för Alkohol och cancer. Insatsen baserades på en befolkningsundersökning som visade fortsatt stora kunskapsluckor om alkohol och cancer. Bland annat i medverkande RCC i TV4 Nyhetsmorgon. Även ett rundabordssamtal i Almedalen har arrangerats på temat alkohol och cancer. I samtalet deltog representanter från FHM, Cancerfonden, SFAM och Systembolaget.

En kartläggning av förutsättningar för att sprida arbetssättet Hälsoinformatörer (HI) nationellt har genomförts. Det har resulterat i fortsatt arbete med att stödja regioner och kommuner, som jobbar enligt HI-principer, att förstärka cancerpreventionsperspektivet.

Inom ramen för ett samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten utarbetades en hälsoekonomisk [rapport](#) om kostnader och sjukdomsburden för hudcancer. Informationsinsatser för hudcancerprevention har också genomförts.

RCC har även deltagit aktivt i EU:S Joint Action Prevent NCD, där flera pilotstudier pågår, exempelvis testas insatser för att öka deltagandet i bröstcancerscreening i socioekonomiskt utsatta grupper inom det så kallade RES-projektet. RCC deltar också i [NORDCAN](#) arbetet, som leds av WHO,

vilket syftar till att förbättra registrering och uppföljning av cancerpreventiva insatser.

Särskild satsning för att utrota livmoderhalscancer

RCC i samverkans arbete med att främja implementeringen av den nationella studie för samtidig HPV-vaccination och testning ("utrotningsprojektet") har samordnats av en tillfällig nationell arbetsgrupp som träffats varje vecka. Gruppen har bestått av en eller två representanter från respektive RCC samt den nationella cancersamordnaren, screeningsamordnaren, en kommunikatör, två personer från studieledningen och en representant från Cancerfonden. Gruppen har inte haft något formellt beslutsmandat utan stöttat varandra i respektive deltagarens beslut om medelsfördelning, kommunikation och liknande. Ett fokus i gruppen har varit att dela erfarenheter om svårnådda grupper. Arbetet med att nå svårnådda grupper har skett lokalt, genom tillfälliga vaccinationsmottagningar i utvalda områden, lokala influencers, hälsoinformatörer och liknande.

RCC i samverkan har ansvarat för och genomfört den nationella kommunikationskampanj som inleddes hösten 2024, Ta gratissprutan mot HPV, och samordnat regionernas användning av kampanjmaterialet. RCC samverkan har också samordnat ett antal vaccinationsevent, till exempel vaccination vid motionsloppet Våruset.

RCC i samverkan har samverkat med Folkhälsomyndigheten, Inera (1177.se) och Cancerfonden för att göra kommunikationen om HPV-vaccination tydlig och sammanhållen. Detta har varit särskilt intensivt i samband med att studien slutar att inkludera samtidigt som regionerna inleder HPV-vaccination enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

När vaccinationerna avslutades den sista juni 2025 var vaccinationstäckningen nationellt 64,7 procent. Variationen i regionerna var mellan 55 och 77 procent. Arbetet fortsätter med att erbjuda en andra dos till vaccinerade.

Tidig upptäckt

Tidig upptäckt i primärvården

Under våren har det nationella primärvårdsnätverket som leds av RCC:s nationella samordnare för tidig upptäckt genomfört en heldagsworkshop med

fokus på tidig cancerupptäckt och regionala skillnader. Det finns en samsyn mellan regionerna kring både framgångsfaktorer och utmaningar i primärvårdens arbete med tidig diagnostik.

Under våren har också ett systematiskt patientsäkerhetsarbete kopplat till cancerdiagnostik i primärvården genomförts med region Stockholm som pilotregion. Vårdcentraler har granskat både avvikelser relaterade till cancerdiagnoser och journaler utifrån symtomdiagnoser med möjlig koppling till cancer. Projektets fokus har varit tidig upptäckt, orsaker till avvikelser och missade möjligheter samt vad vården kan lära av dessa. Bearbetning och sammanställning av materialet pågår.

Ett fortlöpande samverkansarbete sker med de nationella vårdprogramgrupperna för att säkerställa att primärvårdens perspektiv inkluderas i utvecklingen av insatser för tidig upptäckt.

Under våren genomfördes en workshop för att planera ett pilotprojekt kring strukturerad uppföljning av fynd som kan ha cancerrelevans. Piloten är planerad i två regioner, en större och en mindre, för att pröva modellen i olika kontexter. En nationell styrgrupp tillsätts hösten 2025 för att driva arbetet vidare. Det initiala fokusområdet är uppföljning av cystor i bukspottskörteln, så kallade IPMN-cystor, och erfarenheterna kommer att ligga till grund för framtida pilotprojekt, exempelvis kring förändringar på lungorna, så kallade lungnoduli.

Organiserad prostatacancertestning

Under första halvåret 2025 har ytterligare två regioner påbörjat organiserad prostatacancertestning (OPT), vilket innebär totalt 18 regioner. I juli 2025 har 300 000 män erbjudits OPT. Än så länge är det bara en region som nått hela målgruppen 50 till 74 år.

RCC i samverkans nationella arbetsgrupp för OPT samordnar regionernas verksamheter för att skapa nationellt likvärdiga principer, strukturer och kvalitetskrav för OPT. Arbetsgruppen publicerar årligen [nationella rekommendationer](#) för hur OPT bör bedrivas, utvärderar de regionala projekten i förhållande till nationella kvalitetsindikatorer och ser över den nationellt framtagna informationstexten om OPT. Jämlikhetsaspekter för OPT utvärderas i flera regioner. Arbetsgruppen stämmer regelbundet av kunskapsläget med

Socialstyrelsen, så att myndigheten kan påbörja en utredning om ett nationellt screeningprogram för prostatacancer när det finns tillräckligt underlag.

RCC ger fortsatt stöd för nya regioner som startar OPT. I mars genomfördes ett [webbinarium](#) för erfarenhetsöverföring. RCC ger också IT-stöd för OPT och för det nationella kvalitetsregistret för OPT, [SweOPT](#). Data från SweOPT om regionernas verksamheter redovisas öppet på statistik.incanet.se/opt. SweOPT:s styrgrupp sammanställer och kommenterar regionernas resultat i en [årsrapport](#). I juli 2025 har ett tiotal forskningsstudier om OPT publicerats.

EU rekommenderar sedan 2022 sina medlemsstater att utvärdera effekterna av screening för prostatacancer med PSA-prov och magnetkamera, helt i linje med den svenska modellen med OPT. Eftersom den svenska modellen för OPT ännu inte har någon motsvarighet i andra länder, är våra erfarenheter av stor betydelse för införandet av screening för prostatacancer i många europeiska länder. De tre största svenska regionerna medverkar i det EU-finansierade projektet [PRAISE-U](#), som genomför pilotprojekt med OPT i fem europeiska länder (Polen, Irland, Spanien Estland och Litauen). Representanter för svensk OPT samverkar med det tjeckiska nationella screeningprogrammet för prostatacancer som inleddes 2024. Riktat kunskapsutbyte sker även med Norge, Island, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. I början av september var RCC Västs medicinskt ansvariga för OPT inbjuden att prata om organiserad prostatacancer-testning inför Europaparlamentet i Bryssel.

Cancerscreening

Under första halvåret av 2025 har RCC arbetat med att kvalitetssäkra och förbättra det informationsmaterial som används för den återkommande kampanjmånaden om screening för tidig upptäckt av cancer. Alla regioner har inför kampanjmånaden, som infaller i september, fått ta del av det gemensamt framtagna materialet och planerar att utföra egna kommunikationsinsatser under månaden. RCC har planerat för att göra en särskild satsning under kampanjmånaden på att uppmärksamma hinder för transpersoners deltagande i screeningprogrammen och har inlett ett samarbete med företrädare för transorganisationerna.

RCC har även fortsatt arbetet med att implementera digitala kallelser till screening via 1177 för att öka tillgänglighet och förenkla för de invånare som väljer att få information och kallelser från vården via 1177. RCC har tagit fram

nationella digitala kallelsemallar som alla regioner får tillgång till när de börjar använda digitala kallelser via 1177. Fem regioner kan använda de digitala kallelsena via 1177 och fler är planerade att börja använda dem under hösten 2025. Utvecklingen för den tekniska lösningen pågår för såväl det centrala kallelsesystemet för gynekologisk cellprovtagning (HKS) som för det kallelsesystem de flesta regioner använder inom bröstcancerscreening.

De nationella screeningsamordnarna har haft kontinuerliga avstämningar med Socialstyrelsen kring aktuella frågor om cancerscreening. En av de nationella screeningsamordnarna ingår också tillsammans med Socialstyrelsens utredare i ett nordiskt nätverk för screening som träffas varje år för att dela erfarenheter och ta del av omvärldsbevakning inom området. I oktober 2025 kommer en av RCC:s nationella screeningsamordnare delta på ett möte i Utrecht, Nederländerna för att bl.a. delge övriga länder hur Sverige använder AI inom bröstcancerscreening.

Under första halvan av 2025 arrangerade RCC och Socialstyrelsen tillsammans ett samverkansforum för livmoderhalscancerprevention där särskilda utmaningar och förbättringar diskuterades. Fokus på det mötet var främst hur vi säkerställer kvalitet på analyser av HPV-prover. RCC och Socialstyrelsen har under första halvan av 2025 planerat för det årliga dialogforum som sker varje höst där alla screeningprogram bjuds in. För höstens möte kommer innehållet beröra en utökad samverkan mellan primärvården och screeningprogrammen samt statusrapportering från varje screeningprogram.

Alla regioner använder det generiska kallelsesystemet för tjock- och ändtarmscancerscreening idag. Löpande utveckling av systemet pågår. Bland annat har en automatiserad packning av de provkit implementeras. Den används i tjock- och ändtarmscancerscreeningen för att säkra kvaliteten och minska kostnaderna. Under hösten 2025 planeras ytterligare utveckling i form av förbättrad funktionalitet för användarna samt att framtidssäkra lösningen för hållbarhet och flexibilitet över tid.

För gynekologisk cellprovskontroll pågår arbetet med att införa och migrera regionerna till det generiska kallelsesystemet på INCA-plattformen. Nio regioner har gått över och använder det generiska kallelsesystemet. Under resterande del av 2025 kommer fler regioner införa kallelsesystemet med målet att alla regioner är anslutna innan årets utgång. I samband med arbetet har RCC infört ett medicinskt referensråd för att kvalitetssäkra att regionerna i

övergången till det generiska kallelsesystemet också följer det senaste nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention.

Arbetet med att ansluta regioner till det nationella kvalitetsregistret för mammografi har fortsatt under första halvan av 2025. En preliminär anslutningsordning av regioner finns, och möten sker månadsvis med inblandade aktörer (RCC, representanter från regionerna, nationella arbetsgruppen för bröstcancerscreening, Inera, SKR och Sectra). Hittills har 7 regioner (Västernorrland, Värmland, Västmanland, Stockholm, Sörmland, Östergötland och Blekinge) anslutit sig till registret. Ytterligare fyra regioner har sedan en tid startat upp ett arbete för anslutning (Norrbotten, Jämtland-Härjedalen, Dalarna, Uppsala) och fyra regioner har planerat för uppstart under hösten 2025 (Jönköping, Halland, Kronoberg, Örebro).

Under hela 2024 arbetade RCC med en förstudie kring utmaningar och möjligheter med nationella kallelsesystem för fler screeningprogram än tjock- och ändtarmscancerscreening. Det framkom i förstudien att det i dagsläget finns bättre förutsättningar för livmoderhalscancerprevention att eventuellt utveckla ett eller flera nationella kallelsesystem. RCC har under 2025 erbjudit regionerna att delta i ett pilotprojekt för att undersöka och pröva hur samordnade kallelsesystem skulle kunna fungera. Många regioner har inte haft möjlighet att delta p.g.a. journalsystemsbyten. Under hösten 2025 kommer RCC att ta fram ett förslag på struktur och genomförande för ett nationellt kallelsesystem för livmoderhalscancerprevention som kommer presenteras för regionerna.

RCC deltar tillsammans med Socialstyrelsen i åtta arbetspaket inom i Joint Action Cancer Screening (EUCanScreen). Dessa innefattar bl.a. arbeten kring mer jämlik tillgång till screeningprogram, AI-användning inom screening samt kvalitetssäkring av undersökningsmetoder i screeningprogrammen. Under första halvan av 2025 har arbetet intensifierats och RCC har bl.a. tillsammans med Socialstyrelsen deltagit på en workshop i Wien för att dela erfarenheter av att starta upp tjock- och ändtarmscancerscreening. RCC har även deltagit på regelbundna möten kopplat till de arbetspaket där RCC är involverade.

EU Canscreen pågår till och med 2027 och på vilket sätt RCC är involverad i de olika arbetspaketen finns beskrivet på cancercentrum.se

Tillgänglig och god vård med fokus på patienten

Standardiserade vårdförlopp

RCC i samverkan har genom den nationella samordnaren och en projektgrupp med sjukvårdsregionala samordnare fortsatt att vara nationellt stödjande och stimulerande i arbetet med att införa ett gemensamt system med standardiserade vårdförlopp (SVF). Gruppen har månatliga möten för erfarenhetsutbyte och avstämning och är beredande för SVF-frågor inför RCC i samverkans möten.

Samordningen av arbetet med kvalitetsutvärdering av inrapporterade data har fortsatt. Kvalitetssäkringsgruppen ansvarar för den statistik som kontinuerligt uppdateras och visas via cancercentrum.se, och uppdaterar kontinuerligt sidan med frågor och svar om vårdförloppen för att underlätta för regionerna att följa redan framtagna SVF. Gruppen tar regelbundet fram fördjupad statistik för enskilda vårdförlopp för att regionerna ska kunna utveckla sitt kvalitetssäkringsarbete.

Under våren 2025 har utmaningen varit att säkra kommunikation och kontinuerlig dialog med Socialstyrelsen inför övertagandet av väntetidsrapporteringen. Arbete pågår med att tydliggöra den befintliga stödstrukturen för SVF-arbetet och säkra att kommunikation om övertagandet når relevanta mottagare i regionerna. Socialstyrelsen deltog på SVF-samordnarnas fysiska möte i september för att diskutera hur kvalitetssäkring av data kan bibehållas och hur framtida revideringar av SVF bör tas omhand.

Arbete med uppdatering och revidering av befintliga SVF har fortsatt. Njurcancer, malignt melanom och testikelcancer har fastställts i nya versioner för att de ska gå i linje med det nationella vårdprogrammet och utvecklingen av vården för dessa diagnoser.

För att kunna ta vidare de åtgärder som tagits fram inom genomlysningarna av bild- och funktionsmedicin och patologi som genomfördes under 2024 har en ansvarig radiolog projektanställts på deltid under 2025. Förutsättningarna för en nationell upphandling av valideringsplattform kommer att undersökas under hösten. För arbetet inom patologi och bild- och funktionsmedicin har slutsatser

tagits vidare även sjukvårdsregionalt och regionalt, främst via de förbättringsprojekt som tilldelats medel och som ligger väl i linje med genomlysningarnas slutsatser. Arbete med de nationella åtgärderna som rör t.ex. ensning av ledtider inom patologi samt bild- och funktionsmedicin har inte påbörjats utan avvaktar den uppdaterade cancerstrategins slutsatser.

Sverige är i år värd för det årliga nordiska mötet för SVF. Mötet kommer äga rum i Göteborg den 13-14 november och ett hundratal deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Finland är hittills anmälda. Storbritannien som gästade förra årets möte har önskat att delta även detta år och har därför bjudits in till årets möte.

Fortsatt arbete med förbättringsprojekt inom bild- och funktionsmedicin och radiologi

Under tidig vår fördelades medel till 124 projekt varav 32 (26 %) är fortsättningsprojekt. Årets process för ledigkungörande, bedömning samt uppföljning har samordnats och likriktas mellan RCC:erna. En rad projekt har redovisats vid konferenser som Onkologidagarna, Vitalis och Röntgenveckan. Därtill har vardera RCC presenterat projekt genom artikelskrivning samt genom seminarier.

Min vårdplan

Min vårdplan fortsätter att utvecklas som patientens kunskapsstöd inom cancerområdet. Under första halvåret 2025 har det lanserats nya Min vårdplan för fem nya diagnosområden och arbete pågår med att ta fler diagnosanpassningar på barncancerområdet samt framtagande av ytterligare ett par diagnosgrupper. Det pågående projektet med generativ AI verkar kunna korta ledtiderna för att producera nya texter avsevärt. Detta innebär att Min vårdplan nu börjar närma sig målet att täcka in de diagnoser som RCC ansvarar för och där det finns nationella vårdprogram eller motsvarande riktlinjer. Framöver kommer därför arbetet att alltmer riktas in på att uppdatera tidigare publicerat material, öka implementeringstakten och utveckla konceptet vidare.

RCC deltar även fortsatt i relevanta EU-projekt, inte minst EU-CIP, där RCC har en ledande roll när det gäller erfarenhet av att ta fram evidensbaserad patientinformation.

Funktionsgruppen för Min vårdplan fortsätter sitt arbete i takt med aktuella uppdrag och användarnas behov och synpunkter. Gruppen arbetar bland annat med att vidareutveckla stödet till Min vårdplan-användare i vården. RCC fortsätter ge brett stöd till den regionala implementeringen av Min vårdplan genom nätverk för regionala samordnare, förbättrat utbildningsmaterial och de digitala användarträffar som planeras och genomförs av medlemmar i funktionsgruppen.

RCC samarbetar med Inera med att utveckla stöd- och behandlingsplattformen vilket lett till ökade förutsättningar för en effektiv uppföljning, fortsatt implementering och möjlig teknisk vidareutveckling baserat på användarmönster och behov.

Rehabilitering och palliativ vård

Rehabilitering

I samverkan med Socialstyrelsen och Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har en ny KVÅ-kod för bedömning av rehabiliteringsbehov tagits fram och kommer att lanseras januari 2026. Koden är tänkt att användas för insatser på särskild och avancerad nivå. För att identifiera behov av rehabilitering på grundläggande insatsnivå behövs en kod för ”Allmän skattning av behov” som planeras tas fram under hösten 2025 med införande 2027.

I den pågående revideringen av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering kommer de tre nivåerna av insatser att kompletteras med relevanta KVÅ-koder för var nivå. Syftet är att ge stöd till enhetlig användning av KVÅ-koder för cancerrehabilitering. I samarbete med Socialstyrelsen och Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin diskuteras hur implementeringen av en enhetlig användning av KVÅ-koder för rehabiliteringsplan ska realiseras i regionerna.

Den framtagna webbutbildningen riktad till primärvården kring cancerrehabilitering har reviderats och kan nu även användas som kunskapsstöd till specialistvården. Den nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering är representerade i ett nytt svenskt nätverk för träning och cancer som gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, samordnar.

För att öka medvetenheten hos patienter och närstående om cancerrehabilitering har en film inklusive kortversion och poster tagits fram: "Viktigt att veta om Cancerrehabilitering" tillsammans med en kampanj på sociala medier och broschyrer om cancerrelaterad fatigue, "Du som är närstående till någon med cancer" och "Mat under och efter cancerbehandling".

I samband med revideringen av NVP kommer "patientens egna ansvar" att lyftas tydligare vad gäller hälsofrämjande aktiviteter, egenvård/levnadsvanor och stöd från civilsamhället/ideella föreningar.

Fortsatt arbete med förbättringsprojekt inom rehabilitering och palliativ vård

Under våren 2025 har 246 projekt tilldelats medel varav 79 (32 %) är fortsättningsprojekt. Årets process för ledigkungörande, bedömning samt uppföljning har samordnats och likriktas mellan RCC:erna. Projekten och dess resultat har presenterats i en rad olika sammanhang, som nyheter på RCC:s webbplats, nationella och regionala webinarium samt genom att projektledare har bjudits in till RCC-evenemang runt om i Sverige. Regionalt har förbättringsprojekten lyfts och presenterats vid t.ex. nätverksträffar för olika målgrupper där patient- och närståenderepresentanter bjudits in att delta. Patient- och närståenderåd vid olika RCC har haft specifika möten med presentationer av projekten. Ett annat exempel är presentationer på CCC-dagar.

Förbättringsprojekten inom rehabilitering har skapat goda förutsättningar för implementeringen av det nationella vårdprogrammet och strukturerat arbetssättet för cancerrehabilitering. Ett gott exempel är ett digitalt program för prehabilitering som syftar till att stödja, motivera och förbereda patienter inför cancerbehandling via Stöd och Behandling på 1177 där möjlighet undersöks för nationell spridning via RCC i samverkans nationella samordnare för Min vårdplan. Patientens tidiga och viktiga delaktighet i egenvård tydliggörs här.

Palliativ vård

RCC i samverkan genomför flera utbildningsinsatser för att stödja implementering av de nationella vårdprogrammen för palliativ vård (vuxna och barn), samt det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet (PSV) i palliativ vård. Fokus ligger på tidig identifiering av palliativa vårdbehov, till exempel utbildningsfilmer om "Samtal vid allvarlig sjukdom".

Implementeringsarbetet som utgår från PSV palliativ vård sker i samverkan med nationellt programområde för Äldres hälsa och palliativ vård.

Barncancer

Arbetet med insatser har fortsatt under året enligt handlingsplan 2023–2025 inom samtliga nio målområden. Exempelvis har två nya kunskapsstöd publicerats: ett stöddokument för alarmsymtom vid misstanke om cancer hos barn och unga under 18 år och ett nationellt vårdprogram för cancer-rehabilitering för barn och ungdom. Arbetssätt för ett jämlikt införande av precisionsdiagnostik har tagits fram och ett arbete pågår för att kunna uppnå jämlik tillgång till precisionsmedicin och kliniska studier i Sverige.

Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer har reviderats. Det nationella nätverket Uppföljningsmottagningar (UFM) Sverige har etablerats inom RCC-strukturen och nätverket samarbetar för att samtliga uppföljningsmottagningar ska kunna erbjuda adekvat vård och uppföljning enligt det nationella vårdprogrammet.

Min vårdplan ALL barn har reviderats och Min vårdplan Generell barn har tagits fram och kan nu användas för alla diagnoser inom barncancervården. Under året har även diskussioner förts om hur den kvalitetssäkrade patientinformationen som finns i Min vårdplan ska kunna göras mer lättillgänglig för barn och familjer.

Flera insatser pågår för att underlätta kompetensförsörjningsbehovet. I en nationellt gemensam kartläggning finns utbildningsbehoven identifierade och prioriterade.

Nya utbildningar inom intermediärvård och palliativ medicin arbetas nu fram. Arbeta pågår också för att inkludera barncancerperspektivet i befintliga och nya utbildningar som tas fram inom RCC-strukturen.

Kunskapsutveckling samt kompetensförsörjning och forskning

Kunskapsutveckling

Arbete med nationella vårdprogram

Under våren har arbetet med revidering och framtagande av nationella vårdprogram fortsatt. Totalt har 25 vårdprogram och stöddokument uppdaterats på Kunskapsbanken. Ett nytt stöddokument om alarmsymtom vid misstanke om cancer hos barn och ungdomar har publicerats.

För att säkerställa representation från bild- och funktionsmedicin i alla relevanta vårdprogramgrupper har styrdokumentet för vårdprogram kompletterats med att representation från bild- och funktionsmedicin ska utses formellt.

Utifrån resultaten av den nationella utvärderingen av vårdprogrammen har ett arbete inletts för att utveckla kapitlen om uppföljning efter cancersjukdom. Det som behöver ses över är hur rekommendationer förhåller sig till befintlig evidens samt hur en ändamålsenlig uppföljning kan säkerställas både ur ett patient- och resursperspektiv. En arbetsgrupp med representanter från vårdprogramgrupper och från bild- och funktionsmedicin har bildats och kommer att träffas i slutet av september för att diskutera pågående uppföljningsstudier med fokus på hur studiedesign och genomförande kan tas vidare till fler diagnoser, resultat från befintliga HTA-analyser samt förslag på hur uppföljningskapitlen kan förbättras. Arbetet kommer sedan att fortsätta under hösten.

Under våren har den tekniska plattformen för Kunskapsbanken uppdaterats för att öka tillgängligheten för alla kunskapsstöd som presenteras där. Ett arbete har påbörjats för att särskilt förenkla för primärvården att hitta relevanta kunskapsstöd.

Diskussioner om hur vårdprogrammen kan utvecklas med stöd av AI har påbörjats, med utgångspunkt i det arbete som har gjorts inom Min vårdplan.

Arbetet med att ta fram diagnosövergripande indikatorer för en mer enhetlig kvalitetsuppföljning av cancervården har förankrats med alla vårdprogramsordföranden. Indikatorerna inkluderas i kommande uppdateringar av vårdprogrammen.

RCC deltar i arbetspaket 8.2.1 om vårdprogram i EU:s Joint Action EUnetCCC. Sverige har kommit långt när det gäller att ta fram och implementera nationella vårdprogram i förhållande till andra EU-länder, och våra erfarenheter är ett värdefullt bidrag i arbetet.

Arbete med regimbiblioteket

Innehåll och omfattning av regimbiblioteket ökar kontinuerligt med regimer som beskriver nya läkemedel och läkemedelsbehandlingar och även stödbehandlingar som t.ex. läkemedel mot illamående. Barnregimbiblioteket har utökats med flera regimer och bidrar därmed till att behandlingarna ges på samma sätt oavsett var i landet barnet behandlas.

Under våren har ett samarbete med Ineras Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) inletts för att undersöka möjligheten att distribuera regimerna via Sil. Regionerna kan därifrån direkt koppla regimerna till sina vårdadministrativa system. Det vore en långsiktigt hållbar, patientsäker lösning och en möjlighet till att erbjuda alla regioner samma service. Regionerna får redan läkemedelsinformation från andra aktörer (t.ex. FASS) via Sil. Kostnaden för integrationsutvecklingen är dock ett hinder då den bedöms vara hög. Möjliga vägar framåt kommer undersökas under hösten.

Insatser som underlättar uppföljningen av cancervården

Individuell patientöversikt (IPÖ) i cancervården

IPÖ är ett IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Patientöversikten samlar uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt i patientöversikten. Idag finns IPÖ framtaget för åtta cancerdiagnoser, och mer än 70 000 patienter har en startad patientöversikt. RCC i samverkan arbetar med förvaltning och utveckling av IPÖ som ett kunskapsstöd för en effektiv och jämlik cancervård.

RCC i samverkan har fortsatt utveckling av IPÖ genom ett riktat projekt ”IPÖ 2.0”. Satsningen på IPÖ 2.0 avser att bredda tillämpningen från dagens åtta diagnoser till att omfatta alla former av cancer, och därigenom möjliggöra att alla cancerdiagnoser kan ta del av IPÖ:s nyttor. IPÖ 2.0-projektet har även erhållit finansiering via Sjöbergsstiftelsen för att möjliggöra och påskynda utvecklingsarbetet.

Läkemedelsregistrering

I juni 2025 publicerades den senaste rapporten från Register för Cancerläkemedel (RCL). I rapporten ingår 7 667 registreringar om påbörjade behandlingar från 1 januari till 31 december 2024. Bedömningen är att inrapporteringen har ökat med cirka 10 procent jämfört med föregående år. Trots en ökande inrapportering är det fortsatt stora skillnader i rapporteringsgrad mellan regionerna vilket begränsar möjligheten till regionala jämförelser. Därför är det fortsatt viktigt att stärka arbetet med att öka rapporteringsgraden i de regioner där organisationen för registrering ännu inte fungerar optimalt.

Cirka 20 procent av registreringarna som kommer från direktöverföring av data från ordinationssystemet CytoBase i Skåne respektive Västra Götaland. Även Uppsala har kommit igång med överföring från Cytodos i begränsad omfattning och fler regioner arbetar med motsvarande direktöverföringar vilket bör kunna förbättra täckningsgraden framöver.

Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) för en löpande dialog med onkologiklinikernas verksamhetschefer för att motivera en ökad registrering. RCC i samverkan har även återkommande dialog med nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik för att se över möjligheterna till förstärkt uppföljning av läkemedel.

Automatöverföring av strukturerad data

RCC i samverkan arbetar för att förbättra förutsättningarna och skapa lösningar för automatöverföring av data. En del är att stärka möjligheten för att kunna följa data diagnosöverskridande inom specifika specialistområden, vilket ställer nya krav på att variabler och registerstrukturen inom specialistområden ensas mellan olika diagnoser inom cancer. Ett antal diagnosöverskridande indikatorer har tagit fram efter diskussion och förankring med kvalitetsregistergrupper, vårdprogramgrupper, företrädare för verksamhetschefer inom cancerområdet

och CCC-företrädare. Arbete har påbörjats med att införa indikatorerna i vårdprogrammen.

RCC i samverkan arbetar med en utvecklad struktur för att effektivisera informationsförsörjningen för uppföljning av cancervården. Strukturen innebär bättre möjlighet till diagnosöverskridande uppföljning samtidigt som den stödjer både manuell och i olika grad automatiserad informationsförsörjning.

För uppföljning av strålterapi pågår anslutning till ett nationellt kvalitetsregister som informationsförsörjs utan manuell inmatning. Tolv regioner är anslutna i nuläget och övriga regioner arbetar aktivt med att få till fungerande anslutning. Det finns nu en interaktiv utdatarapport tillgänglig på cancercentrum.se. RCC i samverkan arbetar även med att tillgängliggöra informationen från strålterapiområdet till relevanta diagnosspecifika nationella kvalitetsregister inom cancerområdet. Pilotprojektet med automatöversörd strålterapiinformation har skalats upp till ytterligare diagnoser utöver hypofystumörer.

RCC i samverkan arbetar med att analysera och ensa befintliga informationsmängder i register inom cancerområdet för att skapa förutsättningar för automatiserad överföring av information från vårdinformationssystemen. Arbetet sker i dialog med den nationella samverkansgruppen för hälsodata (NSG HD) och dess undergrupperingar för strukturerad vårdinformation, E-hälsomyndigheten och SKR.

Kompetensförsörjning och forskning

Strålbehandling

En omorganisation av den nationella strålbehandlingsgruppen genomfördes i början av 2025, med ordförandebyte och ny uppdaterad uppdragsbeskrivning. Fortsatt gäller dock fokus på frågor som kompetensförsörjning, tillgänglighet, snabbare införande av ny teknik och förbättrade möjligheter till forskning och utveckling. Gruppen samverkar tätt med flera andra aktörer inom området, exempelvis Svensk Strål-onkologisk förening (SSOF), Onkologichefsrådet och sjuksköterskor i cancervård.

Den nya grupperingen arbetade fram remissvar till den nya cancerstrategins skrivning om strålbehandling, en skrivning som innehöll en höjd ambitionsnivå bland annat i form av framtagande av en nationell handlingsplan för svensk

strålbehandling. Arbetet med den nationella handlingsplanen har planerats i samverkan med SSOF och inleds 2025-10-01.

Gruppen fortsätter att vara drivande inom det samnordiska fortbildningsprogrammet för specialistläkare i strålunkologi och en ny fortbildning av sjuksköterskor inom strålbehandling har tagits fram som startar september 2025.

Utvecklingen inom strålbehandling följs med hjälp av RCC genom en årlig enkät avseende resurstillgång. En ny enkät har genomförts våren 2025 och publiceras hösten 2025. Arbetet med att stödja införandet av det Svenska Kvalitetsregistret för radioterapi (SKvaRT) fortsätter.

Comprehensive Cancer Centre

Sedan årsskiftet har RCC i Samverkan haft kontinuerliga möten med etablerade och kommande CCC. Genom gemensamma arbetsgrupper har RCC och CCC arbetat fram fyra områden att initialt arbeta tillsammans med. De fyra områdena är precisionsmedicin, kliniska prövningar, kompetensförsörjning samt sammanhållen vårdkedja och multidisciplinärt arbetssätt. I ett första steg kommer RCC och CCC tillsammans arbeta vidare med precisionsmedicin och kliniska prövningar genom gemensamma arbetsgrupper.

Innovation

RCC i samverkan har ett pågående projekt som syftar till att utveckla ett AI-verktyg för att optimera datahanteringen i register på INCA-plattformen. Projektet genomförs tillsammans med Västra Götalandsregionen och fokuserar på att omvandla ostrukturerad löptext i patologiutlåtanden till strukturerade data och därigenom öka effektiviteten och noggrannheten i rapporteringen till såväl Cancerregistret som nationella kvalitetsregister. Syftet är att minska den manuella arbetsbelastningen samt att säkerställa enhetlighet och kvalitet i insamlade data.

Utbildningar

RCC erbjuder en rad utbildningar med varierande innehåll för att underlätta implementeringen av nya kunskapsunderlag och kompetensförsörjningen i cancervården.

Under våren och sommaren 2025 har RCC bland annat färdigställt en ny webbutbildning om arbetsmiljöansvar vid handhavande av cancerläkemedel och ett utbildningsmaterial med filmer och reflektionsstöd om samtal vid allvarlig sjukdom. Befintliga utbildningar har uppdaterats och använts som underlag i flera insatser. RCC har också omarbetat den tidigare utbildningen för patient- och närståendeföreträdare och sammanfogat den med utbildningen ”RCC, en orientering” för processledare och andra medarbetare i vården.

RCC arbetar löpande med kunskapshöjande insatser i form av webinarier, informationskampanjer och liknande. Exempel på ämnen under våren 2025 är prevention (levnadsvanor, solvanor, alkohol) rehabilitering (lymfödem, mat under behandling, digital rehabilitering) och palliativ vård. Ytterligare en kunskapshöjande insats är att Cancerrådgivningen, som tidigare enbart vänt sig till Region Stockholm, har blivit nationell och även välkomnar vårdpersonal som behöver stöd eller råd.

RCC har även arrangerat olika regionala utbildningar utifrån behov samt deltagit i undervisningen vid utbildningar som arrangeras av universitet och högskolor.

Ökad tillgång till kliniska studier

RCC i samverkans nationella arbetsgrupp för klinisk forskning har uppdraget att verka för jämlik och ökad tillgång till kliniska studier för alla patienter, bl.a. genom att utveckla förutsättningarna för den kliniska forskningen på mindre enheter. En nationell enkätundersökning har genomförts för att kartlägga förutsättningarna för kliniska studier inom cancervården. Resultaten har analyserats och sammanställts i en rapport som belyser nuläget samt föreslår åtgärder för att förbättra möjligheterna för kliniska studier. Rapporten ligger på cancercentrum.se

Rapporten bygger på enkätsvar från drygt 400 respondenter från samtliga sjukvårdsregioner, kompletterat med djupintervjuer avseende goda exempel som identifierats. Särskild vikt läggs vid hur förutsättningarna för kliniska studier på mindre enheter kan stärkas för att tillgodose en jämlik tillgång till kliniska studier. Rapporten har spridits till relevanta aktörer och utgör en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att stärka förutsättningarna för kliniska studier inom cancerområdet.

Vidare fokuseras det nationella arbetet på att stärka samverkan med Comprehensive Cancer Centers, med Kliniska studier Sverige för att tillgängliggöra utbildningar av relevans inom cancerområdet, samt med Cancerstudier i Sverige i syfte att utveckla och öka användningen av databasen.

Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Precisionsmedicin

Under våren har det bildats en arbetsgrupp för vidare arbete med den handlingsplan som togs fram under 2024. Arbetsgruppens uppdrag är att leda implementering av handlingsplanen på en övergripande nivå och består av företrädare från olika regionala verksamheter, Genomic Medicine Sweden (GMS), RCC och CCC. Under det första halvåret har samverkan etablerats med universitetssjukhusens initiativ som arbetar med Färdplan för implementering av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården. För att undvika parallella spår ingår den nationella cancersamordnaren i styrgruppen för Färdplan för implementering av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården.

Stöd för användandet av AI

Samtliga RCC har inom den särskilda satsningen på bilddiagnostik fördelat medel till införande av AI-stöd vid bildgranskning vid bröstmammografi. Därutöver finns projekt även inom andra diagnoser som berör bilddiagnostik och dosplanerings-CT samt flödes- och kvalitetsförbättrande åtgärder för PET/DT-verksamheten med hjälp av AI. Inom patologisatsningen finns en rad projekt som avser förbättrad diagnostik samt förkortade ledtider med hjälp av AI-verktyg. Införande av AI-verktygen innebär även förändrade arbetssätt och kompetenshöjande åtgärder.

Cancer genomik

Den nationella arbetsgruppen för cancer genomik och molekylär patologi har bedömt och vid behov kommenterat samtliga vårdprogramstexter på remiss. Parallellt har fokus för arbetet legat på övergripande frågor kring vårdprogramstexter, stöd till arbetet inom RCC i samverkan kring genomförande av handlingsplan för jämlikt införande av precisionsmedicin samt svar på inkommande frågeställningar kring behov av nya molekylära analyser. Under året har den nationella arbetsgruppen även tagit sig an ett nytillkommet uppdrag att kravställa strukturerad data inom cancer genomik, som definieras inom

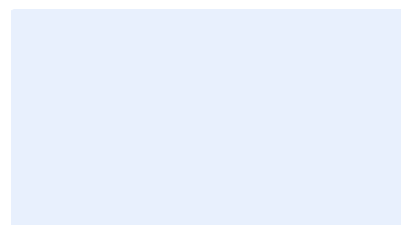
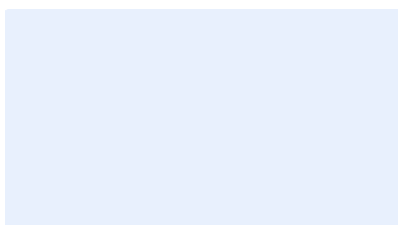
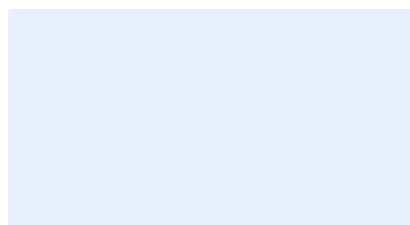
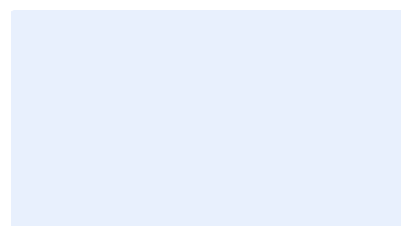
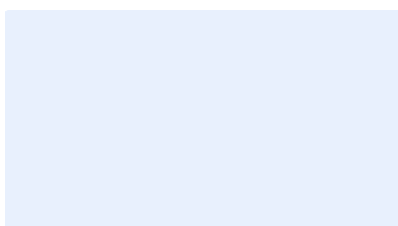
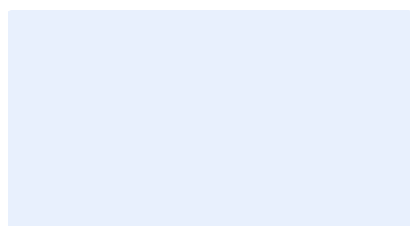
domänområdet ”Genomik”. Gruppen har också haft i uppdrag att stödja enskilda verksamheter inom området cancergenomik med det samarbete som skett inom Genomic Medicine Sweden (GMS) och respektive Genomic Medicine Center (GMC) har fungerat väl och fyllt denna funktion.

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider

Delrapport om överenskommelsen 2025

Upplysningar om innehållet
Helena Brändström, helena.brandstrom@skr.se

© Sveriges Kommuner och Regioner, 2025
www.skr.se





Samverkansregionala insatser

Delrapport 2025. Samverkansregionala insatser inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR, Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2025.

2025-09-30

Version: 1.0

Versionshantering

Version	Datum	Förändring
1.0	2025-09-30	Fösta vesion

Samverkansregionala insatser, delrapport 2025

Rapporten utgiven av: RCC i samverkan

September 2025

Innehållsförteckning

Kapitel 1

RCC Norr 5

1.1	Prevention.....	5
1.2	Tidig upptäckt.....	5
1.3	Standardiserade vårdförlopp	5
1.3.1	Särskild satsning på bild- och funktionsmedicin i och patologi	5
1.4	Stöd till rehabilitering och palliativ vård.....	6
1.4.1	Särskild satsning på rehabilitering, palliativ vård, aktiva överlämningar och seneffektsuppföljning.....	6
1.5	Min vårdplan	6
1.6	Barncancerområdet.....	7
1.7	Kunskapsutveckling samt uppföljning av cancervården.....	8
1.8	Kompetensförsörjning och forskning	8

Kapitel 2

RCC Mellansverige 9

2.1	Prevention.....	9
2.2	Tidig upptäckt.....	9
2.3	Standardiserade vårdförlopp	9
2.3.1	Särskild satsning på bild- och funktionsmedicin och patologi	10
2.4	Stöd till rehabilitering och palliativ vård.....	10
2.4.1	Särskild satsning på rehabilitering, palliativ vård, aktiva överlämningar och seneffektsuppföljning.....	11
2.5	Min vårdplan	11
2.6	Barncancer.....	11
2.7	Kunskapsutveckling samt uppföljning av cancervården.....	12
2.8	Kompetensförsörjning och forskning	12

Kapitel 3

RCC Stockholm Gotland 14

3.1	Prevention.....	14
3.2	Tidig upptäckt.....	15
3.3	Standardiserade vårdförlopp	16
3.3.1	Särskild satsning på bild- och funktionsmedicin i och patologi	16
3.4	Stöd till rehabilitering och palliativ vård.....	17
3.4.1	Särskild satsning på rehabilitering, palliativ vård, aktiva överlämningar och seneffektsuppföljning – insatser 2025	18
3.5	Min vårdplan	19
3.6	Barncancerområdet.....	19

3.7	Kunskapsutveckling samt uppföljning av cancervården.....	20
3.8	Kompetensförsörjning och forskning	22

Kapitel 4

RCC Sydöst..... 23

4.1	Prevention.....	23
4.2	Tidig upptäckt.....	23
4.3	Standardiserade vårdförlopp	23
4.3.1	Särskild satsning på bild- och funktionsmedicin i och patologi	24
4.4	Stöd till rehabilitering och palliativ vård.....	24
4.4.1	Särskild satsning på rehabilitering, palliativ vård, aktiva överlämningar och seneffektsuppföljning – insatser 2025	25
4.5	Min vårdplan	25
4.6	Barncancerområdet.....	26
4.7	Kunskapsutveckling samt uppföljning av cancervården.....	27
4.8	Kompetensförsörjning och forskning	27

Kapitel 5

RCC Syd

5.1	Prevention.....	29
5.2	Tidig upptäckt.....	29
5.3	Standardiserade vårdförlopp	29
5.3.1	Särskild satsning på bild- och funktionsmedicin och patologi	30
5.4	Stöd till rehabilitering och palliativ vård.....	30
5.4.1	Särskild satsning på rehabilitering, palliativ vård	30
5.5	Min vårdplan	31
5.6	Barncancerområdet.....	31
5.7	Kunskapsutveckling samt uppföljning av cancervården.....	31
5.8	Kompetensförsörjning och forskning	32

Kapitel 6

RCC Väst..... 33

6.1	Prevention.....	33
6.2	Tidig upptäckt.....	33
6.3	Standardiserade vårdförlopp	34
6.3.1	Särskild satsning på bild- och funktionsmedicin i och patologi	34
6.4	Stöd till rehabilitering och palliativ vård.....	35
6.4.1	Särskild satsning på rehabilitering, palliativ vård, aktiva överlämningar och seneffektsuppföljning – insatser 2025	36
6.5	Min vårdplan	36
6.6	Barncancerområdet.....	36
6.7	Kunskapsutveckling samt uppföljning av cancervården.....	37

KAPITEL 1

RCC Norr

1.1 Prevention

RCC Norr samarbetar med regionernas folkhälsoenheter för att förbättra levnadsvanor i norra sjukvårdsregionen, med fokus på tobak, alkohol och fysisk aktivitet. En kommun i respektive region ingår i ett pilotprojekt med hälsoinformatörer, där rekrytering och utbildning av hälsoinformatörer pågår.

1.2 Tidig upptäckt

RCC Norr stödjer det nationella arbetet med ärftlig cancer. I norra sjukvårdsregionen finns den cancerogenetiska mottagningen organisatoriskt under RCC Norr. Mottagningen utreder familjer med ärftligt ökad cancerrisk. Remissinflödet ökar, men varierar mellan regionerna. Utbildningar genomförs för ökad kunskap och jämlik remittering. Personer med konstaterad ärftlig risk remitteras till kontrollprogram och interventioner enligt nationella vårdprogram. RCC Norr utreder nu möjligheter att sjukvårdsregionalt organisera kontroller för personer med ärftligt ökad cancerrisk och därmed förbättra jämlik tillgång till uppföljning och interventioner.

1.3 Standardiserade vårdförlopp

RCC Norr stödjer regionernas SVF-arbete genom samordning, utbildning och workshoppar. Fyra SVF har analyserats för att identifiera orsaker till långa väntetider. I juni arrangerade RCC Norr en digital workshop för respektive diagnos, där varje region redovisade resultatet av sina analyser och identifierade förbättringsområden.

1.3.1 Särskild satsning på bild- och funktionsmedicin i och patologi

RCC Norr har utlyst och fördelat medel till projekt som syftar till att främja tillgängligheten inom bild- och funktionsmedicin och patologi. År 2025 har 10 projekt inom patologi och 21 inom bilddiagnostik tilldelats medel. RCC Norr följer upp projekten och ger stöd vid behov. Vid de sjukvårdsregionala

cancerdagarna i maj presenterades flera framgångsrika förbättringsprojekt som fick medel 2024.

1.4 Stöd till rehabilitering och palliativ vård

RCC Norr stödjer implementeringen av nationella vårdprogram för cancerrehabilitering och bäckencancerrehabilitering genom dialogmöten, utbildningar och utvecklingsprojekt. Arbetet sker både inom diagnosprocesser och via en sjukvårdsregional arbetsgrupp, där RCC Norr finansierar lokala processledare i regionerna. Strukturerade behovsbedömningar ökar.

Ett Kraftens Hus har etablerats i Östersund, med stöd från RCC Norr. Många förbättringsarbeten pågår för att stärka patientens förmåga till en aktiv rehabilitering.

RCC Norr är nationellt stödjande RCC för palliativ vård. De sjukvårdsregionala processledarna är även koordinators för sjukvårdsregionens palliativa kompetenscentrum. Nationella webbutbildningar om samtal vid allvarlig sjukdom har tagits fram för att stödja införandet av vårdförloppet för palliativ vård, och fler informationsfilmer är under produktion. Utbildningar har hållits för personal inom både regioner och kommuner i norr.

1.4.1 Särskild satsning på rehabilitering, palliativ vård, aktiva överlämningar och seneffektsuppföljning

RCC Norr har 2025 utlyst och fördelat medel till totalt 41 förbättringsprojekt inom de aktuella områdena. RCC Norr följer upp projekten och ger stöd vid behov. Vid de sjukvårdsregionala cancerdagarna i maj presenterades flera framgångsrika förbättringsprojekt som fick medel 2024, varav flera har fått fortsatta anslag 2025.

1.5 Min vårdplan

RCC Norr är nationellt stödjande RCC för Min vårdplan. Antal verksamheter och diagnoser som använder Min vårdplan ökar fortlöpande i norra sjukvårdsregionen liksom antalet startade vårdplaner via 1177. RCC Norr erbjuder stödresurser och samordnar erfarenhetsutbyte.

1.6 Barncancerområdet

Personal som tidigare rekryterats genom barncancersatsningen fortsätter sitt arbete. Läkare och kontaktsjuksköterskor på hemsjukhusen är viktiga resurser, särskilt för barn med komplexa behov. Personalen erbjuds kontinuerligt professionell handledning.

Uppföljningsmottagning i form av ”nyckelbesök” erbjuds alla barncancerpatienter i sjukvårdsregionen vid 13, 17 och 18 års ålder, samt uppföljande besök vid 25 års ålder. Uppföljningsverksamheten fortsätter att utvecklas. Multidisciplinär samverkan kring cancerpredisposition mellan RCC Norr och barnonkologen är etablerad och vidareutvecklas.

Verksamheter i sjukvårdsregionen kan söka medel för förbättringsprojekt inom barncancerområdet.

Genomfört arbete under första halvåret 2025:

- GAP-analys för barncancerrehabilitering är slutförd, fokus ligger nu på implementering av vårdförloppet.
- Pediatriskt palliativt kompetenscentrum, PPKC-Norr har etablerats för att främja likvärdig palliativ vård för barn i hela sjukvårdsregionen.
- Hemsjukvård erbjuds barn med cancer inom 45 min från Umeå.
- GMS-analyser är klinisk praxis för alla barn med cancer.
- Vårdsalar har tonårsanpassats och ett särskilt tonårssrum har öppnats på barnonkologen.

Fortsatt och pågående arbete under 2025:

- Anpassning av lokaler både på barnonkologen i Umeå och på hemsjukhus i regionerna.
- Barnonkologiska hemsjukvårdsprojekt i regionerna fortsätter att utvecklas.
- Samarbetet med Hjältarnas Hus i Umeå fortsätter.
- Ackrediteringsarbetet för Umeå Comprehensive Cancer Centre fortsätter.
- PPKC-Norr utvecklar arbetssätt och utbildningsdagar genomförs i alla norr-regioner.

1.7 Kunskapsutveckling samt uppföljning av cancervården

Arbetet enligt den sjukvårdsregionala cancerplanen för 2022–2024 har slutredovisats och en ny cancerplan för 2025–2028 har fastställts. RCC Norr samordnar sjukvårdsregionala konsekvensbeskrivningar och implementering av vårdprogram och SVF, i samverkan med regionala aktörer. Uppföljning sker genom dialog- och regionmöten och genom cancerplanens uppföljning. Kvalitetsregisterarbete stöds genom utbildningar och analyser.

RCC Norr deltar aktivt i det pågående ackrediteringsarbetet för Umeå CCC, tillsammans med Region Västerbotten och Umeå universitet.

1.8 Kompetensförsörjning och forskning

RCC Norr stödjer optimerat kompetensnyttjande och vidareutbildning inom cancervården. Utbildningar, kunskapsdagar och seminarier genomförs regelbundet. De sjukvårdsregionala cancerdagarna hade i år omkring 300 deltagare.

Digitala arbetssätt används brett för samverkan, utbildning och utvecklingsprojekt. AI-lösningar ingår i flera pågående satsningar inom bilddiagnostik och patologi och för framtagande av kunskapsstöd.

RCC Norr bidrar med statistisk kompetens till registerforskning och ansvarar för datauttag ur kvalitetsregister.

KAPITEL 2

RCC Mellansverige

2.1 Prevention

Under första halvåret har ett särskilt fokus legat på att samverka med TPLR (Tobaksprevention i landets regioner), CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen i Uppsala län med flera aktörer. Tillsammans arrangeras LUFT 2025, Sveriges största konferens inom nikotin- och tobaksområdet, som äger rum i Uppsala i september 2025. Konferensen samlar nationella och internationella experter för att främja hälsa, förebygga ohälsa samt driva utvecklingen av tobaks- och nikotinprevention framåt.

2.2 Tidig upptäckt

RCC Mellansverige har initierat det samverkansregionala projektet ”Förstudie basal cancergenetik”, i syfte att kartlägga att det finns etablerade strukturer som säkerställer ett jämlikt och systematiskt omhändertagande samt uppföljning av personer med ärftlighet för cancersjukdom, och om dessa strukturer behöver utvecklas. Arbetet med projektet syftar till att möta den ökande efterfrågan på cancergenetiska utredningar genom att stärka mottagningskapaciteten i respektive region för basal utredning inom fem prioriterade diagnosgrupper. Mer komplexa och ovanliga fall föreslås att som tidigare remitteras till Klinisk genetik i Uppsala eller Örebro. Projektets resultat planeras att redovisas för Samverkansnämndens ledningsgrupp under våren 2026, som därefter får ta ställning till ett eventuellt utökat arbete med ärftlig cancer inom varje region.

2.3 Standardiserade vårdförlopp

Under första halvåret av 2025 har RCC Mellansverige samordnat regionernas arbete med redovisning av måluppfyllelsen inom SVF. För de regioner som infört det nya journalsystemet Cosmic under samma tidsperiod har överföringen av väntetidsdata till Signe-databasen inte fungerat pga. tekniska brister i Cosmic. Detta har i hög grad påverkat arbetet negativt men med stödet från RCC Mellansverige kommer samtliga regioner utom en att uppfylla målet att över 70 % av alla nya cancerfall inkluderas i SVF.

Rapporterna till Socialstyrelsen kommer innehålla en kartläggning av patienter med fyra utvalda cancerdiagnoser som överskridit förväntad ledtid med 50 % eller mer. Kartläggningen ger värdefull insikt om flaskhalsar och utvecklingsområden som regionerna behöver arbeta med.

RCC Mellansverige stödjer aktivt verksamheternas utveckling av nya arbetssätt för att öka följsamheten och effektiviteten i SVF. Arbetet sker till exempel i diagnosspecifika vårdprogramgrupper och i professionsnätverk där samarbeten och patienternas vårdflöden är huvudfokus. RCC Mellansveriges bedömning är att täta, regelbundna uppföljningar i det sjukvårdsregionala arbetet är fortsatt nödvändigt för att uppnå jämlik vård av hög medicinsk kvalitet.

2.3.1 Särskild satsning på bild- och funktionsmedicin och patologi

Under 2025 fördelade RCC Mellansverige drygt 24 miljoner till 16 projekt inom bild- och funktionsmedicin och 10 projekt inom patologi. Flera av projekten bedömdes vara till nytta för hela sjukvårdsregionen. Fem av projekten hade beviljats medel under 2024 och tilldelades under 2025 ytterligare medel till fortsatt arbete.

2.4 Stöd till rehabilitering och palliativ vård

Regional arbetsgrupp för cancerrehabilitering har under året fortsatt implementeringen av det nationella vårdprogrammet med fokus på uppföljning och KVA-koder. Information om RCC:s webbutbildningar och informationsfilm har spridits. En undersökning har påbörjats om hur regionernas webbplatser kan stödja samverkan och överlämning. Ett webinarium om sex och cancer har genomförts.

Uppdragsutbildningen ”Rehabilitering vid cancer i bäckenområdet”, 7,5 hp, har anordnats i samarbete med Karlstads universitet. Utvärderingen visade hög klinisk relevans, och flera utvecklingsprojekt har initierats.

Nationellt samverkansarbete kring digital cancerrehabilitering har påbörjats.

Sex lokala patientsamverkansprojekt har initierats som del i en satsning på egenvård.

Arbetet med att lyfta palliativ vård i sjukvårdsregionala grupperingar pågår kontinuerligt.

2.4.1 Särskild satsning på rehabilitering, palliativ vård, aktiva överlämningar och seneffektsuppföljning

År 2025 fördelade RCC Mellansverige drygt 20 miljoner till 57 projekt inom rehabilitering (31) och palliativ vård (26) varav 15 är fortsättningsprojekt från 2024. Projekt som genomfördes år 2024 har gett inspiration till projekt som beviljats medel 2025, där andra regioner och diagnosområden nu gör likadana aktiviteter för att skapa förbättringar. Nio initiativ arbetar med att stärka cancerrehabilitering och palliativ vård för barn och unga vuxna.

2.5 Min vårdplan

Utbildning och handledning om Min vårdplans innehåll, användning och funktionalitet har hållits frekvent under året, framför allt för sjuksköterskor i sjukvårdsregion Mellansverige.

Dessutom deltar en representant från RCC Mellansverige i månatliga nationella införandemöten vilka är viktiga för att plocka upp förbättringar och goda exempel som kan användas inom sjukvårdsregionen.

2.6 Barncancer

Stödjande insatser har bland annat utförts genom internat för palliativa ombud tillsammans med projektledare för palliativa förbättringsarbeten. Gruppen har sett över gemensamma sjukvårdsregionala dokument och rutiner. Översynen visade att det finns behov för kartläggning av hemsjukvård för barn med palliativa vårdbehov, som planeras ske under året med enkätutskick.

Implementering av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering för barn och ungdom pågår i flera engagerade regioner.

Transitionssköterska är tillsatt i Uppsala från hösten 2025 för att öka samverkan mellan Barn- och Ungdomsklinik och Uppföljningsmottagningen.

Samarbetet inom sjukvårdsregionen fortsätter genom ”Virtuell klinik”. En sjukvårdsregional vårdplatskoordinator har inrättats i Uppsala och samverkansformer utarbetas för planerade behandlingar och insatser.

2.7 Kunskapsutveckling samt uppföljning av cancervården

RCC Mellansverige är en aktiv aktör i utvecklingen av mer användbara rapporter från de cancerspecifika kvalitetsregistren för uppföljning och utveckling av den regionala och nationella cancervården. Rapporterna ger vården tillgång till aktuell diagnosspecifik samt kliniskspecifik uppföljning av hur diagnostik och behandling bedrivs inklusive behandlingsresultat, något som är en förutsättning för att kunna säkerställa kvalitet och bedriva utveckling.

Ett relativt nytillkommet uppdrag är stödet till Uppsala Comprehensive Cancer Center (UCCC) där RCC Mellansverige ingår. En viktig komponent är att stödja framtagandet av statistik och kvalitetsdata.

Lösningar för patientrapporterade mått (PROM och PREM) ingår i utbudet samt delges till UCCC genom aktiv representation från RCC Mellansverige i deras arbetsgrupper för patientrapporterade mått och kvalitetsutveckling. Rapporteringen till Register för cancerläkemedel (RCL) varierar mellan regionerna varför data från RCL ännu inte kan användas fullt ut för att jämföra verksamheternas läkemedelsanvändning. Under våren 2025 genomfördes dock förändringar i några regioners ordinationssystem vilket i framtiden kan underlätta en automatisk överföring av data till RCL.

RCC stödjer framtagande och årlig revision av nationella vårdprogram (NVP) inom cancer. RCC Mellansverige har dessutom ett nationellt administrativt ansvar för de drygt 50 NVP-gruppernas möten och arbete. Implementeringen av NVP i sjukvårdsregion Mellansverige stöds genom ett tjugotal regionala vårdprocessgrupper.

Spridningen av nya metoder följs löpande upp genom kvalitetsregistren.

2.8 Kompetensförsörjning och forskning

RCC Mellansverige är nationellt ansvarigt för införandet av kvalitetsregisterbaserade randomiserade kontrollerade studier (R-RCT), vilket underlättar genomförandet av akademiska kliniska studier. Arbetet med kompetensförsörjning sker framför allt genom erbjudande av vidareutbildning av befintlig personal, till exempel bäckencancerrehab och koloskopikurs, men också genom ekonomiskt stöd till verksamheter som annars inte skulle ha



råd att skicka medarbetare, till exempel mammografisjuksköterskeutbildning och hematologisjuksköterskors vidareutbildning.

RCC Mellansverige ansvarar för FICA-nätverket (Forskningssjuksköterskor inom cancer) och arrangerar nätverksmöten två gånger per år. RCC Mellansverige stödjer även forskning genom att tillsammans med Lif Mellansverige arrangera ett årligt samverkansforum.

KAPITEL 3

RCC Stockholm Gotland

3.1 Prevention

Flera parallella satsningar pågår för att sprida kunskap och erfarenheter kring arbetssättet med hälsoinformatörer (som sprider information till allmänheten om cancerprevention). RCC Stockholm Gotland (SG) utbildar och samordnar fortsatt utveckling av Region Stockholms hälsoinformatörer, stöttat Region Gotlands införande av rollen samt RCC Norrs projekt att införa rollen i flera regioner och kommuner inom ramen för EU:s Joint Action Prevent NCD.

Hälsoinformatörernas arbete inom region Stockholm har under 2025 till stor del fokuserats på insatser kring HPV-vaccination. Genom dessa insatser har framgångsrik samverkan inletts med flera nya aktörer inom civilsamhället (exempelvis den ideella organisationen Mama United och Röda Korset) som i sin tur lett till vidare samverkan kring andra riskfaktorer (exempelvis kost och fysisk aktivitet).

RCC SG har under våren haft en aktiv roll i framtagandet av nationell utbildning kring levnadsvanor i samverkan med NPO levnadsvanor. Vi har också bidragit med analys, expertis samt finansiering till en [vetenskaplig artikel om kunskap och attityder kring cancerriskfaktorer bland allmänheten](#) som publicerades i BMC Public Health under våren 2025.

RCC SG stödjer på olika sätt den nationella arbetsgruppen för cancerprevention i arbetet med den nationella cancerpreventionsplanen.

RCC SG deltog under våren vid Järvaveckan med informations- och kommunikationsinsatser kring levnadsvanor samt cancerprevention inklusive HPV-vaccination. Under våren 2025 har utbildning genomförts för RCC:s medarbetare om kostens betydelse för cancerrisk.

3.2 Tidig upptäckt

Under året har flera fortbildningsaktiviteter genomförts inom sjukvårdsregionen för primärvårdens personal, med fokus på tidig upptäckt av cancer.

Insamlingen inom patientsäkerhetsprojektet i primärvården är slutförd och analysen har inletts. Projektet har haft särskilt fokus på tidig upptäckt av cancer, orsaker till avvikelser och missade möjligheter samt lärdomar för vården. Bearbetning och sammanställning av materialet pågår.

Arbetet med att uppdatera och regionalt anpassa primärvårdens vårdprogram för cancer på viss.nu fortsätter löpande, inklusive samverkan kring vårdövergångar.

En workshop har genomförts för att planera ett pilotprojekt kring strukturerad uppföljning av premaligna pankreasfynd, där Region Stockholm kommer ingå. Planering har också startats för systematisk uppföljning av lungnoduli.

Försöksverksamheten med riskbaserad lungcancerscreening har fortsatt under året. Resultatet från den första pilotstudien har analyserats och skickats in till vetenskaplig tidskrift (sommaren 2025). Pilotstudie 2 pågår och inklusionen beräknas vara klar vid årsskiftet. Bilddiagnostik utvärderas med AI-lösning och manuell granskning.

Under våren 2025 presenterades en rapport avseende [Sociodemografiska skillnader i deltagande i en riktad lungcancerscreening – En uppföljning från Region Stockholm](#).

Försöksverksamheten inom OPT (organiserad prostatacancertestning) har också fortsatt enligt plan. Under 2025 har en övergång skett till digitaliserad kommunikation via Kivra och 1177.

Under 2025 har stort fokus lagts på utrotningsprojektet livmoderhalscancer där kvinnor födda 1994–1998 erbjudits HPV-vaccinering. När inklusionen avslutades i juni 2025 hade 69 874 personer vaccinerats i Region Stockholm. Barnmorskor, verksamhetsutvecklare/läkare, kommunikatörer och sjuksköterskor från RCC SG har deltagit och arrangerat en stor mängd informations-, kommunikations-, och vaccinationsinsatser i dialog med olika aktörer.

Insatser har också genomförts för att HPV vaccinera riskgrupper (män som har sex med män, personer med hiv-infektion samt kvinnor som behandlats för dysplasi).

I juni 2025 avslutades inklusionen i det så kallade RES-projektet (Res enkelt till screening). Projektet leds av RCC SG och genomförs i samarbete med vårdgivare, Storstockholms lokaltrafik och Strålfors.

Projektet (som ingår i EU:s Joint Action Prevent NCD) utvärderar om fria resor med kollektivtrafik ökar deltagande i bröstcancerscreening med mammografi i områden med lågt deltagande. Utvärdering och hälsoekonomisk analys pågår. Preliminära resultat och erfarenheter presenterades på International Congress on Cancer Nursing i Adelaide i juni 2025.

3.3 Standardiserade vårdförlopp

RCC Stockholm Gotland har under 2025 fortsatt att stödja sjukvårdsregionens vårdgivare i SVF-arbetet. Den regionala arbetsgruppen fortsätter att på olika sätt underlätta SVF-arbetet i dialog med vårdgivarna och de regionala processledarna. Automatöverföring av SVF-data från journalsystem till INCA-plattformen, vilket ger ett effektivare resursutnyttjande i vården (den tidigare manuella registreringen minskar avsevärt), har fortsatt och breddats ytterligare under året. Dialogmöten och utbildningsinsatser har genomförts. Analysen (bland annat journalgranskningar) av patienter i SVF som väntat > 50 % över målledtiden pågår i nära samverkan med vårdgivarna och leds av de sjukvårdsregionala processledarna. Flera förbättringsprojekt med syfte att effektivisera vårdkedjorna och korta ledtiderna har beviljats och pågår inom ramen för överenskommelsen 2025.

3.3.1 Särskild satsning på bild- och funktionsmedicin i och patologi

Flera långsiktiga kompetenssatsningar pågår. Bland annat har den första utbildningen av så kallade histotekniker avslutats och 11 personer examinerats. Det möjliggör kompetensväxling mellan histotekniker, biomedicinska analytiker och läkare och leder till en mer flexibel och effektiv arbetsfördelning inom patologi. En digital plattform för patologer som själva ska kunna öva och bedöma sina diagnostiska färdigheter håller på att etableras. Arbete pågår med att ta fram den första testmodulen som innefattar endometrium samt HER2-diagnostik vid bröstcancer. Dessa områden är särskilt viktiga då korrekt tolkning av biomarkörer är avgörande för att välja rätt behandling, särskilt vid målstyrd cancerterapi.

Det långsiktiga arbetet med att bygga upp den molekylärdiagnostiska verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset, som stöds av RCC SG, kan nu visa att väsentligt fler cancerpatienter får molekylär diagnostik till väsentligt kortare svarstider. Breda genpaneler används reflexmässigt för kolorektal-, prostata-, spridd bröst-, och endometriecancer. Barncancer och sarkom analyseras rutinmässigt med helgenomsekvensering, vilket ger snabbare och mer precisa diagnoser samt möjliggör bättre behandlingar.

Stödet till det strategiska arbetet med bild- och funktionsmedicin i Region Stockholm har involverat samtliga verksamhetschefer som nu gemensamt arbetar för effektivare bemanning och en utvecklad röntgensjuksköterskeutbildning (utländska radiografer utbildas till röntgensjuksköterskor).

Inom radiologin i Region Gotland har ett flertal utbildningsinsatser genomförts för att höja den generella kompetensen inom mammografin och därigenom minska sårbarheten. En radiolog har påbörjat utbildning inom mammografi och nödvändig utrustning har köpts in.

Flera av förbättringsprojekten testar och utvärderar AI-lösningar inom bilddiagnostik, strålbehandling samt patologi.

3.4 Stöd till rehabilitering och palliativ vård

De sjukvårdsregionala processledarna för cancerrehabilitering arbetar med implementering av vårdprogrammen samt informations-, och utbildningsinsatser. Dialog och samverkan sker löpande med sjukvårdsregionens vårdgivare inom rehabilitering samt med andra aktörer från civilsamhället, som t.ex. Kraftens Hus och föreningen Ung Cancer.

De sjukvårdsregionala processledarna för palliativ vård har deltagit i styrgruppen för det nationella vårdprogrammet för vuxna samt varit vårdprogramshandläggare för motsvarande för barn. Under 2025 har fokus legat på revidering och remissrundor inför publicering hösten 2025/våren 2026, med efterföljande implementeringsarbete.

Under våren 2025 har arbetet fortsatt med statistisk analys för att påvisa eventuella omotiverade skillnader i tillgång till palliativ vård (med avseende på kön, ålder, socioekonomisk status och anpassade riktade åtgärder).

Arbetet med att ta fram utbildningsmaterial om palliativ vård (som vänder sig till patienter och närstående) har fortsatt. Planering och inspelning pågår av en film (del 3 i en serie), denna gång med fokus på livets slutskede.

Insatser avseende övriga utbildningsaktiviteter har fortsatt under våren i samarbete med bland annat ”Palliativa veckan”, en serie nationella webbföreläsningar framtagna av den nationella arbetsgruppen i palliativ vård samt andra utbildningsinsatser tillsammans med Palliativt kunskapscentrum i Region Stockholm.

3.4.1 Särskild satsning på rehabilitering, palliativ vård, aktiva överlämningar och seneffektsuppföljning – insatser 2025

Inom ramen för de särskilda satsningarna som ingår i canceröverenskommelsen 2025 pågår 37 förbättringsprojekt (20 inom rehabilitering, 14 inom palliativ vård samt tre projekt som innefattar både rehabilitering och palliativ vård).

Inom rehabilitering sker fortsatt omfattande utveckling (genom en rad delprojekt) av Centrum för cancerrehabilitering med fokus på personcentrering, jämlik vård, egenvård och kunskapsuppbyggnad. Andra projekt fokuserar på rehabiliteringsprocessen inom sjukvårdsregionens akutsjukhus, med särskilt fokus på så kallad prehabilitering. Här ingår även förbättringsarbeten för att stödja utvecklingen inom Kraftens Hus, både i Stockholm och på Gotland. Här pågår initiativ inom psykosocialt stöd, vårdnavigator samt egenvård och levnadsvanor.

De palliativa projekten fokuserar bland annat på att stärka vårdprocesser på flera akutsjukhus genom konceptet Kloka kliniska val, kortare ledtider till strålbehandling och jämlik tillgång till palliativ vård. Förbättrad nutrition vid palliativ vård för både vuxna och barn är mål för tre projekt. Andra utvecklar digitala stöd, bland annat digital vårdtolk, automatisk screening av palliativa vårdbehov och distansmonitorering inom vårdformen avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

Ett projekt som påbörjades 2024 och har fortsatt 2025 är inrättandet av en så kallad transitionssjuksköterska för att stärka övergången mellan barn, - och vuxencancervård. Insatser beskrivs vidare under punkten barncancer. Flera förbättringsprojekt pågår för att specifikt förbättra den palliativa vården för barn, bland annat inom hospice.

3.5 Min vårdplan

Införandet av Min vårdplan har fortsatt under 2025. Min vårdplan används nu vid majoriteten av mottagningarna på samtliga sjukhus i Stockholm, på Gotland samt vid två privata urologimottagningar. Totalt finns 22 olika versioner av vårdplaner i bruk. För att stödja fortsatt användning och utveckling av arbetssätt, genomförs regelbundna uppföljningar i arbetsgrupperna av införandestödjare från RCC. RCC SG har fortsatt att arrangera regionala nätverksträffar samt digitala utbildningstillfällen under våren 2025 för de som arbetar med Min vårdplan.

RCC SG deltar aktivt i det nationella utvecklingsarbetet inom Min vårdplan.

3.6 Barncancerområdet

Under 2025 har fokus i det sjukvårdsregionala arbetet främst legat på följande områden:

- Fortsatt utveckling av kontaktsjuksköterskerollen inom barncancer.
- ”Borta bra men hemma bäst”-projektet som startade upp 2024 med förbättringskursen i RCC SG:s regi. Här implementeras nya arbetssätt för ökad möjlighet till behandling i hemmet (exempelvis avslutande av intravenös infusion i efter cytostatikabehandling för tonåringar).
- Dagboken för stamcellstransplanerade barn implementeras i ordinarie arbetssätt.
- Strålbehandlingen och pedagogiskt resurscentrum har skapat ny rutin med lekterapi som del i förberedelserna inför strålbehandling, i syfte att minska behov av narkos.
- Införande av standardiserade patientplaneringar i journalsystemet för ökad patientsäkerhet och enhetlighet.
- Apotekarrollens kompetensstige har tydliggjorts och underlättat teamsamarbetet kring läkemedelsfrågor – från läkemedelsberedning, ”off label”, nya läkemedel, till uppföljning av läkemedelsanvändning på verksamhetsnivå. Som ett resultat ses apotekarrollen blir självklar och starkt kopplat till implementeringen av precisionsmedicin.
- Implementering av precisionsmedicin i klinisk rutin pågår med utveckling av så kallad ”Molecular Tumour Board” regionalt och nationellt med koppling till kliniska studier.
- Samverkan med Region Gotland sker med regelbundna möten mellan barnsjukvården i Visby och processledarna.

- Transitionssköterskerollen för överföring till vuxenvård finns på plats och deltar i samarbetsprojekt mellan verksamheterna för att utveckla och etablera rollen.
- Utbildning och administrativa förberedelser för start av nyckelmottagning för patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation (första mottagningsbesöket planerat till hösten 2025). Två ytterligare barnonkologer är introducerade på uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer i syfte att skapa en hållbar struktur för framtiden.
- Ny rutin etablerad med hjärtmottagningen för att uppfylla de nya kraven i det nationella vårdprogrammet. Rutinen kommer att utvärderas och sannolikt justeras för att effektivisera patientflödet.
- Det så kallade SOL-teamet (symtomlindring och livskvalité), ett interdisciplinärt team för palliativ vård av barn, har under våren fortsatt etableringen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Antalet akuta sjukhusinläggningar har minskat som en konsekvens. Målet är att teamet blir en del av ordinarie verksamheten från och med 2026, med regional finansiering.
- En PREM-undersökning har genomförts som visar hög patient- och anhängarnöjdhet gällande både vård och bemötande.
- På uppdrag av NAG barncancer har genomfört en GAP-analys av aktuell status för cancerrehabilitering av barn och ungdom i Stockholm jämfört med den som rekommenderas i NVP cancerrehabilitering av barn och ungdom. I GAP-analysen framkom att det största gapet återfanns under perioden efter genomgången cancerbehandling. Som en konsekvens etableras nu ett interprofessionellt rehabiliteringsteam. Teamet kommer initialt ta emot alla barn och familjer som är färdigbehandlade för cancer för en kartläggning av rehabiliteringsbehov. Utifrån identifierade behov kommer sedan rehabiliteringsinsatser att erbjudas och följas upp. Det nya teamet börjar ta emot patienter i september.

3.7 Kunskapsutveckling samt uppföljning av cancervården

RCC SG har under våren 2025 vidareutvecklat uppföljningen av cancervården genom att kombinera regionala och nationella datakällor. VAL-databaserna används för regelbunden uppföljning av cancerincidens samt vårdkonsumtion avseende strålbehandling, kemoterapi och kurativt syftande kirurgi. Genom Mosaic-gruppernas sociodemografiska klassificering har skillnader i vård och

behandlingsmönster identifierats, vilket påvisar behovet av fördjupade analyser av orsaker och konsekvenser.

Det regionala tumörregistret (RTR) utgör fortsatt underlag för analyser av överlevnad i olika cancerformer. Eftersom RTR saknar uppgifter om behandlingar och sociodemografiska faktorer har RCC etablerat en koppling med VAL i syftet att stärka möjligheterna till uppföljning av cancervården. En utvecklad tillgång till data och strukturerad återkoppling till vårdgivarna förväntas förbättra förutsättningarna för en transparent, enhetlig och jämlik uppföljning av cancervården i regionen.

RCC SG stödjer regionernas rapportering till läkemedelsregistret genom en teknisk struktur för säker och automatiserad dataöverföring till INCA. Strukturen är generell och skalbar, vilket underlättar införande i olika vårdssystem.

Parallellt har RCC SG utvecklat en informationsstruktur för uppföljning av medicinsk onkologisk behandling, där insamlade data kan delas vidare till diagnosspecifika kvalitetsregister. Detta stärker den nationella kunskapsstyrningen och möjliggör fördjupad analys av behandlingsresultat.

RCC SG har även samarbetat med den nationella arbetsgruppen för CAR-T-behandling för att identifiera variabler för uppföljning av denna patientgrupp, vilket bidrar till systematisk kunskapsutveckling kring avancerade behandlingar.

När nya kunskapsstöd kommer på remiss samordnar RCC SG regionens svar genom sakkunniga, hälsoekonomer och vid behov primärvården. Efter sammanställning har remissvaren beslutats genom delegationsbeslut av hälso- och sjukvårdsdirektören. Genom denna struktur skapas förutsättningar för en enhetlig och resurseffektiv implementering som stärker både vårdens kvalitet och jämlikheten i cancervården. I region Stockholm-Gotland ansvarar RCC för att nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp implementeras genom regionala arbetsgrupper. Dessa grupper analyserar organisatoriska och ekonomiska konsekvenser samt omsätter nationella rekommendationer till en regional tillämpning utifrån tillgängliga resurser, kompetenser och organisatoriska förutsättningar. Arbetssättet utvecklas löpande avseende integration med kunskapsstyrningsorganisationen.

3.8 Kompetensförsörjning och forskning

Under våren 2025 har RCC SG genomfört den årliga kartläggningen av kompetensförsörjning inom sjukvårdsregionen. I denna kartläggning rapporterar vårdgivarna det aktuella läget avseende bemanning samt behov av kompetensutveckling. Årets resultat indikerar ett positivt trendbrott: fler verksamheter beskriver en mer stabil bemanningssituation och uppger att det finns större utrymme för utvecklingsarbete jämfört med tidigare år.

Kartläggningen 2025 markerar den tionde i ordningen, och i samband med detta har RCC Stockholm Gotland tagit fram en [sammanställande rapport som omfattar perioden 2016–2025](#). Rapporten fokuserar på utvecklingen inom bemanning, rekrytering och kompetensutveckling under denna tidsperiod.

Ett önskemål från vårdgivarna har varit att utbildningsmaterial ska göras mer lättillgängligt. Som ett svar på detta har RCC SG samlat det digitala utbildningsmaterialet på en utbildningsplattform.

Nationella läroplanen för uppdragsutbildningen Kontaktsjuksköterska i cancervård 7,5 hp har uppdaterats och en ny upphandling av kursen har genomförts. Uppdraget gick till Marie Cederschiöld högskola.

Flera förbättringsarbeten pågår inom ramen för årets särskilda satsningar, med syfte att förbättra kompetensförsörjningen, t.ex. inom bilddiagnostik, endoskopi och palliativ vård.

RCC SG har under året stöttat forskning (expert- och analysstöd samt finansiellt stöd) inom tidig upptäckt av cancer, patientdelaktighet, cancerprevention, palliativ vård, patientsäkerhet samt AI-baserade insatser.

KAPITEL 4

RCC Sydöst

RCC Sydöst tar fram en samlad resultatredovisning som beskriver uppföljning utifrån sex patientlöften. I [Resultatredovisningen](#) finns fördjupad information kring flera av nedanstående områden.

4.1 Prevention

Processledaren har aktivt deltagit i NAG preventionsarbete, vilket utgått från handlingsplanen utifrån den nationella cancerpreventionsplanen. I Sydöst har kunskapshöjande insatser genomförts i form av samarbete med processer för cancerrehabilitering, prostatacancer, hudcancer ärftligt cancer, patient- och närstående rådet samt återkommande träffar med de regionala cancerrehabiliteringsgrupperna i Sydöst, NAG levnadsvanor och Linköping Comprehensive Cancer Center, LCCC.

4.2 Tidig upptäckt

Processledaren för ärftlig cancer har inlett samarbete med bröstcancerprocessen i syfte att klargöra rekommendationer och diskutera snabbspår. Dialog om snabbspår har även påbörjats med processen för kolorektalcancer. Avstämning med barncancerprocessen har påbörjats avseende utredning och uppföljning av friska syskon. Processledaren för ärftlig cancer har också arbetat som ordförande för nationellt vårdprogram för ärftliga tumör risksyndrom hos vuxna och barn.

4.3 Standardiserade vårdförlopp

Den sjukvårdsregionala SVF-samordnaren har sedan 2024 en RAG SVF och möter kontinuerligt regionala SVF-samordnare. RCC sydösts processledare genomför med stöd av processamordnare och vid behov med stöd av sjukvårdsregional och/eller regional SVF-samordnare möten för dialog om resultat, tolkning av kriterium, registrering av aktuella koder samt validitet i de resultat som publiceras.

RCC:s diagnosspecifika processledare fick i uppdrag att samordna arbetet med granskning inom ”sin” sjukvårdsregionala processgrupp med resultatet att

processledarna vid en hearing skulle föredra ”sina” findings för varandra. Hearingen gav möjlighet för RCC:s processledare att fånga och samordna gemensamma utvecklingsområden samt få inblick/möjlighet att stödja regionala processgrupper. Hearingen avslutades med att regionala SVF-samordnare redogjorde för hur de handlingsplaner som skapats kommer omhändertas inom respektive region, hur de planerar att stödja och följa upp arbetet med identifierade regionala utmaningar/handlingsplaner.

4.3.1 Särskild satsning på bild- och funktionsmedicin i och patologi

Inom Patologi inkom 10 ansökningar varav 7 beviljades medel, och inom Bild- och funktionsmedicin inkom 15 ansökningar varav 9 beviljades medel. Fokus har varit att projekten ska främja tillgänglighet och ha påverkan på ledtider inom närtid. Pågående projekt presenteras på [RCC:s webbplats](#). RCC Sydöst kommer att ha en andra ansökningsomgång (1 september) för att fördela kvarvarande medel, och kommer då att prioritera projekt som främjar samarbete inom patologi eller inom bilddiagnostik i Sydöst och mellan kliniker och patologi/bilddiagnostik.

Regionalt programområde medicinsk diagnostik har haft ett sjukvårdsregionalt projekt med syfte att öka samverkan mellan alla patologienheter. Projektet fortsätter att utvidgas under 2025.

4.4 Stöd till rehabilitering och palliativ vård

Cancerrehabilitering

En rutin för att klargöra och underlätta aktiv överlämning (inklusive remissförfarande) gällande rehabiliteringsbehov från universitetssjukhusets kliniker till övriga sjukvårdsregionen är under framtagande. Nätverk för lymfterapeuter, de som arbetar med fatigue och de som arbetar med sexuell hälsa inom Sydöstra sjukvårdsregionen har skapats för att främja ett jämlikt strukturerat arbetssätt i hela sjukvårdsregionen. Bland annat är en broschyr under framtagande för patienter med fatigue som framöver kommer vara 1177-anpassad och tillgänglig nationellt. För en mer detaljerad beskrivning om aktiviteter i respektive region, se [Resultatredovisningen](#).

Palliativ vård

Processledarrollen för palliativ vård inom RCC har utökats till en processledare per region (processledare för Kalmar län är dock ännu inte tillsatt) samt

en gemensam processamordnare för Sydöstra sjukvårdsregionen. Samverkan sker med diagnosspecifika processgrupper regionalt samt processgrupper i palliativ vård nationellt. Mer detaljerad information om pågående aktiviteter finns i [Resultatredovisningen](#).

4.4.1 Särskild satsning på rehabilitering, palliativ vård, aktiva överlämningar och seneffektsuppföljning – insatser 2025

Utifrån medel från överenskommelsen för 2024 mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beviljades medel till 25 projekt i vår region för att stärka cancerrehabiliteringen och göra den mer jämlik. Flera av projekten är övergripande för hela Sydöstra regionen. Några av projekten presenterades på RCC Sydösts webinarium ”Dela, lära och förbättra” den 21 mars. Alla projekt som tilldelats medel i respektive sjukvårdsregion finns på [RCC:s webbplats](#). För Sydösts projekt finns även en poster för respektive projekt som beskriver hur projekten genomförts och resultaten.

År 2025 har 30 projekt beviljats medel inom rehabilitering i SÖSR. Några av projekten är nya och några är fortsättning på redan uppstartade förbättringsprojekt. Några projekt 2025 har som mål att förbättra processerna kring övergång från barn till vuxna och framtagande av struktur och organisation för stöd till unga vuxna. Medel har även beviljats för att stärka kompetensen på Uppföljningsmottagningen för unga vuxna. Olika typer av ”cancerskolor” kommer att genomföras där patienter är med och skapar programmet tillsammans med vården. Medel har även beviljats till ett fortsättningsprojekt där Medborgarskolan genomför träffar för cancerpatienter som ett stöd att ta hand om sig själva efter genomförd behandling och knyta kontakter med andra personer med cancer, vilket var mycket uppskattat under 2024. Respektive regions projekt får stöttning av processledarna för cancerrehabilitering i SÖSR.

4.5 Min vårdplan

RCC sydöst stödjer implementeringen av Min vårdplan genom att ha en person i varje region som har rollen som införandestödjare, de samverkar för att underlätta implementeringen. Min vårdplan har införts gemensamt och används i hela sydöstra sjukvårdsregionen för mer än 25 diagnoser.

Implementeringsarbetet fortsätter löpande regionalt och sjukvårdsregionalt av projektledarna. Implementeringsarbetet för Min vårdplan matstrups- och magsäckscancer 2025 pågår.

4.6 Barncancerområdet

- Processledaren för barncancerprocessen RCC Sydöst håller ihop och samverkar aktivt med Linköping Comprehensive Cancer Center, LCCC.
- Besök inom SÖSR (under våren 2025 möte med Jönköping och Norrköping och till hösten Kalmar, Västervik och Norrköping) angående barncancerprocessen, för ökat samarbete, diskussion och utbyte.
- Implementering av nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn samt för barncancerrehabilitering för barn och ungdom pågår.
- En projektgrupp för genomlysning av hemsjukvård och palliativ vård i sydöstra sjukvårdsregionen har med hjälp av RCC Sydöst och RPO Barn och ungas hälsa arbetat vidare för syftet att ge god och jämlik i hela regionen. Projektet pekade ut flera förbättringsområden som påbörjades 2024 och fortsatte in i 2025. Under våren 2025 skapades även en RAG Palliativ vård för barn.
- Det första mötet angående implementering av Nationellt vårdprogram ärftlig cancer hölls i april.
- Dokument ”Alarmsymtom för tidig upptäckt av barncancer” sprids till barnmottagningar, primärvård och skolhälsovård.
- Videokonferenser med Norrköping, Motala, Kalmar, Västervik samt Jönköping genomförs regelbundet.
- Min vårdplan har utökats till samtliga barncancerdiagnoser genom att en generell Min vårdplan har tagits fram.
- Nyckelbesöken vid 13, 17 och 18 års ålder genomförs tillsammans med ett multiprofessionellt team och erbjuds till alla barn/ungdomar efter genomgången cancerbehandling.
- GMS-projektet har övergått från forskning till klinik. Projekt har påbörjats tillsammans med patolog och precisionsmedicin med syfte att korta svarstider, Projekt för implementering i klinik har beviljats medel från satsningen 2025.
- Processarbete kring hantering av biopsipreparat pågår.
- Ny rutin för remissväg och ansvarsfördelning vid misstänkt tumör i rörelseapparaten är framtagen i samråd med ortopederna och regionen.
- Ny rutin för tillvaratagande av färskt material vid operation utanför ordinarie arbetstid (kvällar, nätter och helger) har arbetats fram.

- Omstrukturering av den paramedicinska gruppen vid de olika uppföljningarna (nyckelbesök och IRENE uppföljningar) till följd av Region Östergötlands varsel inom gruppen pågår.
- Flera förbättringsprojekt och föredrag har gjorts med stöd av stimulanspengar från RCC, till exempel ”Trygga barn vid magnetkameraundersökning” och ”Implementering av precisionsmedicin inom barncancer som klinisk rutin”.
- Exempel på projekt på kliniken under våren är:
 - ”MASCOT, en studie för barn i cytostatikabehandling”, med avsikt att förbättra psykiskt mående med fysisk aktivitet.
 - ”Bildstödsprojekt”, som drivs av två barnsköterskor som under våren slutfört vidareutbildning barn och ungdom är implementerat.
 - ”Studie med infusionspåsar i väst för barnen”, avslutad under våren.

4.7 Kunskapsutveckling samt uppföljning av cancervården

I [Resultatredovisningen](#) finns fördjupad information kring resultat och uppföljning av cancervården i Sydöst, både diagnosspecifika rapporter och en samlad rapport vilken även följer upp patienternas upplevelse av vården.

RCC Sydöst har hög täckningsgrad i cancerläkemedelsregistret och vi ligger bland regioner med högsta täckningsgrad. Data från cancerläkemedelsregistret används av Regionala arbetsgrupper (RAG) för onkologi och cancerläkemedel vid fortlöpande diskussion om förskrivning av cancerläkemedel i Sydöst.

RCC Sydöst ansvarar för framtagande och revidering av nio nationella vårdprogram.

För att underlätta implementering av nya och reviderade kunskapsstöd tas en sjukvårdsregional konsekvensbeskrivning fram vid remissrundorna. Den sprids sedan till de som berörs. Remissrutinerna innebär samarbete med övriga regionala programområden (RPO) i Sydöst.

4.8 Kompetensförsörjning och forskning

Flera av 2024 och 2025 års förbättringsprojekt syftar till att förbättra processer, arbetssätt, uppgiftsväxla och samverka i sydöst tex genom att prova lösningar i en region och sedan sprida arbetssätten i hela sjukvårdsregion.

Nätverkssamverkan pågår inom många områden vilket är ett annat sätt att



likrikta vård och rehabilitering. RCC Sydöst är fortsatt involverade i flera utbildningsinsatser för vårdpersonal inklusive framtaget utbildningspaket för medarbetare i cancervården. Efter en flera års satsning kring uppstart av en så kallad cytostatikakörkorts-utbildning i Region Östergötland är det äntligen i gång med en utbildning på Lära Nära plattform i egen regi.

För att sprida erfarenheter från 2024 års förbättringsarbeten genomfördes under våren 2025 den välbesökta digitala konferensen Dela lära och förbättra. Alla som beviljades medel fick göra en digital poster som redovisades på våra hemsidan för spridning till alla som inte hade möjlighet att delta.

KAPITEL 5

RCC Syd

5.1 Prevention

De 12 råden som finns i [den europeiska kodexen mot cancer](#) samt RCC i samverkans [nationella plan för cancerprevention](#) utgör basen för RCC Syds arbete med prevention. RCC Syds regionala patientprocessledare (RPPL) för prevention ingår i RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerprevention, och samverkar med regionalt programområde (RPO) Levnadsvanor i Södra sjukvårdsregionen. Insatser kring HPV-vaccination i syfte att utrota livmoderhalscancer har varit en stående punkt på möten med regionernas cancersamordnare.

5.2 Tidig upptäckt

RCC Syd har erbjudit regionerna i Södra sjukvårdsregionen finansiellt stöd för etablering av lokala strukturer för omhändertagande av personer med ökad risk för ärftlig cancer. RCC Syds RPPL för ärftlig cancer ingår i den sjukvårdsregionala funktion för ärftlig cancer (SFÄC) som har startat vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Funktionen arbetar för en jämlik och evidensbaserad uppföljning av patienter med ökad risk för ärftlig cancer.

I uppdraget ingår att stödja och samordna:

- kunskap, utbildning och kompetensutveckling
- framtagande av och implementering av rutiner och strukturer för handläggning och systematisk uppföljning vid ärftlig cancer
- klinisk forskning inom området
- uppföljning av den samlade verksamheten i Södra sjukvårdsregionen.

5.3 Standardiserade vårdförlopp

SVF är en central del i RCC Syds regionala patientprocessarbete. RCC Syd stödjer regionernas SVF-analyser genom dialog, samordning och journalgenomgång för att identifiera felaktigt inrapporterade data och samla in kompletterande information som underlag för analyserna. Resultat och föreslagna åtgärder diskuteras på möte med regionernas cancersamordnare

och kommer att ingå som en del i sjukvårdsregionala ledtids- och kvalitetsdatorapporter som är under utveckling (se nedan).

5.3.1 Särskild satsning på bild- och funktionsmedicin och patologi

RCC Syd har beviljat medel till 12 förbättringsprojekt inom bilddiagnostik och 9 förbättringsprojekt inom patologi. Fem av projekten, däribland förstärkt infrastruktur för MDK i Södra sjukvårdsregionen, innebär en fortsättning på förbättringsarbeten som initierades 2024.

5.4 Stöd till rehabilitering och palliativ vård

RCC Syd stödjer och följer upp regionernas införande av de nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering respektive palliativ vård genom nätverksträffar, utbildningsinsatser och möten med regionala processledare. Bäckencancerrehabiliteringskoordinator med uppdrag att stödja regionala utbildningsaktiviteter och nätverk inom bäckencancerrehabilitering är etablerad. Ett webinarium med fokus på handläggning av radioterapeutiska symptom/komplikationer efter behandling för bäckencancer genomfördes i februari. Flera projekt med fokus på utveckling av digitala lösningar för cancerrehabilitering och palliativ vård pågår, bland annat personcentrad digital och interaktiv palliativ vård, digitalt program för prehabilitering respektive cancerrelaterad fatigue, digital kognitiv testning och digital cancerrehabilitering för unga.

RCC Syds patient- och närstående råd driver frågan om etablerande av mötesplatser för cancerberörda i Södra sjukvårdsregionen. I början av året genomfördes ett möte med representanter från Kraftens hus för att diskutera möjlig uppstart av verksamhet inom Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Center (SUHCCC). Dialog förs även med representanter från Doris Rehab som är en fysisk mötesplats för cancerpatienter och närstående. I Region Halland har en mötesplats med fokus på livskvalité för cancerdrabbade och patienter med en obotlig sjukdom etablerats inom ramen för ett förbättringsprojekt.

5.4.1 Särskild satsning på rehabilitering, palliativ vård

RCC Syd har beviljat medel till 42 förbättringsarbeten inom rehabilitering och palliativ vård. Några projekt beviljades endast del av det ansökta beloppet. 23 projekt rör rehabilitering, 16 projekt rör palliativ vård och 3 projekt rör både

rehabilitering och palliativ vård. Flera projekt är en fortsättning på förbättringsarbete som inleddes under 2024. Ett heldagsmöte för samtliga projektledare kommer att genomföras i början av hösten i syfte att utbyta erfarenheter och etablera samverkan mellan projekten.

5.5 Min vårdplan

Samtliga regioner i Södra sjukvårdsregionen har erbjudits finansiellt stöd för införande och förvaltning av Min vårdplan. RCC Syd följer upp och stödjer arbetet fortlöpande, bland annat genom att delta och informera på sjukvårdsregionala möten. I februari arrangerades ett heldagsmöte för sjuksköterskor i cancervård med fokus på Min vårdplan och cancerrehabilitering.

5.6 Barncancerområdet

Flera insatser som syftar till ett gott och jämlikt omhändertagande av barnonkologiska patienter i Södra sjukvårdsregionen pågår, bland annat stärkta förutsättningar för att behandling och uppföljning ska ske på hemsjukhusen. Under våren har en sjukvårdsregional gap-analys genomförts som underlag för en framgångsrik implementering av nationellt vårdprogram cancerrehabilitering för barn och ungdom. Ett sjukvårdsregionalt konsultteam för palliativ vård av barn är etablerat.

Insatser med fokus på att stärka medicinskt och psykosocialt omhändertagande av patienter på Uppföljningsmottagningen vid Skånes universitetssjukhus pågår.

5.7 Kunskapsutveckling samt uppföljning av cancervården

RCC Syd har drygt 50 regionala patientprocessledare i vars uppdrag det ingår att stödja implementeringen av SVF och nationella vårdprogram. Uppdraget inkluderar att föra en regelbunden dialog kring ledtids- och kvalitetsregisterdata i syfte att identifiera såväl utvecklingsbehov som goda exempel.

I samarbete med Södra sjukvårdsregionens kansli utvecklas en generisk arbetsmodell för kontinuerlig uppföljning och förbättring av tillgänglighet och kvalitet i Södra sjukvårdsregionen. Arbetet, som sker på uppdrag av Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp, fokuserar på framtagande av rapporter som



inkluderar ledtider, kvalitetsindikatorer inklusive patientrapporterade mått och rekommenderade insatser från regionala patientprocessledare.

5.8 Kompetensförsörjning och forskning

Erfarenheter av nya arbetssätt delas regelbundet på möten med regionala patientprocessledare. Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Center (SUHCCC) utgör en viktig arena för stärkta förutsättningar för klinisk forskning. I februari arrangerades ett webinarium med fokus på patientens roll i klinisk forskning. Södra sjukvårdsregionens tumörbiobank innehåller nu tio provsamlingar inom olika cancerdiagnoser. RCC Syd genomför regelbundet kommunikationsinsatser kring provsamlingarna, band annat genom en artikel i Onkologi Sverige i mars.

RCC Syd ger finansiellt stöd till två AI-projekt. Det ena projektet fokuserar på utökad användning av AI som stöd för analyser, detektion och klassifikation av prostatacancer och det andra projektet är en fortsättning på ett projekt med fokus på patientsäkert införande av AI inom patologi.

KAPITEL 6

RCC Väst

6.1 Prevention

Tyngdpunkten i det preventiva arbetet läggs i den nationella arbetsgruppen för cancerprevention då insatserna även kommer det sjukvårdsregionala arbetet till del. Sjukvårdsregionala insatser under delåret har innefattat att arrangera föreläsningar för allmänheten om cancerprevention, deltagande i ett västsvenskt tobaksnätverk och spridning av information om sunda solvanor i samverkan med BVC.

Arbetet för att nå en täckningsgrad om minst 70 % i projektet Eliminera HPV och livmoderhalscancer genom ikappvaccination av kvinnor födda 1994–1999 har varit intensivt och ställt högra krav på samverkan med vård- och samhällsaktörer. I Västra Götalandsregionen (VGR) nåddes en täckningsgrad på 67,8 % och i Region Halland 71,4 %.

6.2 Tidig upptäckt

RCC Väst stödjer utvecklingen av regionala strukturer för omhändertagande av personer med ärftlighet för cancersjukdom genom behandlingsnära genetisk testning (BenGT) i VGR. Det är ett samarbete mellan bröstcancercentrum och cancergenetisk mottagning för att säkerställa en jämlik tillgång till kontroller och interventioner för berörda individer.

Implementeringsstudien för lungcancerscreening sker i samverkan med RCC Norr och löper på enligt plan. Målet är att studien ska bidra med underlag till Socialstyrelsens utredning om ett nationellt screeningprogram.

Genom arbete med de nationella kvalitetsregistren för mammografiscreening och organiserad prostatacancertestning, samt det nationella processregistret för livmoderhalscancerprevention skapar RCC Väst förutsättningar för att följa upp, utvärdera och utveckla insatser kring tidig upptäckt inom flera diagnosområden.

6.3 Standardiserade vårdförlopp

RCC Väst stöttar VGR:s förvaltningar i arbetet med att ta fram redovisningar av arbetet med SVF samt i att samordna det övergripande regionala arbetet med SVF. Detta görs genom en arbetsgrupp, som leds av RCC Väst, bestående av representanter från regionens olika förvaltningar. Både arbetssätt och uppföljning representeras i form av lokala SVF-samordnare samt så kallade SVF-Superusers.

RCC väst stöttar förvaltningarna i deras arbete med utvecklingen av nya arbetssätt för att öka följsamheten till SVF. De lokala SVF-samordnarna samlas i SVF-arbetsgruppen för att uppmärksamma flaskhalsar, utbildningsbehov eller andra svårigheter hos de respektive förvaltningarna. En del av arbetet går ut på att lyfta goda exempel på arbetssätt som fungerat på vissa verksamheter eller förvaltningar, för att sprida dessa inom regionen.

RCC Väst stöttar regionens förvaltningar med insatser som syftar till att stärka kvalitetsutvärdering av SVF. RCC väst driver gruppen för SVF-Superusers, vilka arbetar för likvärdig registrering och bättre kvalitet på SVF-data. Gruppen arbetar med att stötta respektive förvaltnings personal. Det så kallade "Delledtidsprojektet" pågår under 2025, där ett verktyg för visualisering av delledtider möjliggörs med hjälp av data i redan befintliga system.

RCC väst leder förvaltningarnas arbete att i utvalda SVF, identifiera systematiska hinder som leder till att väntetiderna överskrids med mer än 50 % än den optimala ledtiden i SVF. RCC Väst har stöttat i att välja förlopp och besluta arbetssätt. När förvaltningarna har genomfört sina respektive kartläggningar ansvarar RCC Väst för att sammanställa en rapport baserad på SVF-arbetsgruppens slutsatser.

6.3.1 Särskild satsning på bild- och funktionsmedicin i och patologi

För att främja tillgängligheten inom bild- och funktionsmedicin och patologin samt nå en högre måluppfyllelse av det nationella ledtidsmålet för SVF har RCC Väst beviljat fem förbättringsprojekt inom patologi och åtta inom bild- och funktionsmedicin. Uppföljning av projekten sker kontinuerligt och rapporteras även till Socialstyrelsen. Samtliga projekt finns redovisade i gemensamt nationellt dokument på [RCC:s webbplats](#).

6.4 Stöd till rehabilitering och palliativ vård

RCC Väst stödjer fortsatt implementeringen av det nationella vårdprogrammet för palliativ vård och det personcentrerade sammanhållna vårdförloppet. En regional medicinsk riktlinje (RMR) har tagits fram som samordnar dessa dokument och underlättar tillämpningen i VGR. Flera förbättringsprojekt har beviljats inom canceröverenskommelsen, med fokus på tidig identifiering av palliativa behov, samverkan mellan vårdnivåer och ökad vård i hemmet. Utbildningsinsatser kring samtal vid allvarlig sjukdom och allmän palliativ vård fortsätter. Den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för palliativ vård, med representation från sjukhus, primärvård, kommunal vård, närvårdsamverkan, hospice och närstående, bidrar till samverkan mellan vårdnivåer och vårdgivare.

RCC Väst samverkar med Kraftens hus Sjuhärad respektive Göteborg inom ramen för rehabilitering bland annat genom interventionen ”Vägen framåt med Kraftens hus – att hitta styrka och mål” som syftar till att hjälpa till att mobilisera tillgängliga resurser hos de cancerdrabbade men också öppna upp för förändring och utveckling. RCC Väst är också drivande i en regional utredning för att undersöka förutsättningarna för att ingå ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kraftens hus efter 2026.

RCC Väst samverkar också med Ung Cancer för ökad kunskap om och stöd till målgruppen samt spridning av framgångsrika arbetssätt.

RCC Väst samverkar både multidisciplinärt och multiprofessionellt för att öka och sprida kunskapen om bäckenrehabilitering. Behovet av spetskompetens och forskning träder fram då det rör sig om ytterst komplexa insatser avseende sexuell dysfunktion, strålenterit, strålcystit och lymfödem. Komplexiteten ökar också behovet av samverkan med andra specialister. Cancerrehabilitering är en stående punkt på omvårdnadsgruppmöten där större fokus ofta handlar om sexuell hälsa och bäckenrehabilitering.

RCC Väst stödjer uppbyggnaden av Regionalt centrum för cancerrehabilitering. Centrumet erbjuder både digitala och fysiska insatser för patienter med avancerade rehabiliteringsbehov. Arbetet baseras på multiprofessionella bedömningar och insatser. RCC Väst stödjer också det arbete som pågår i NU-sjukvården för att erbjuda helt digital cancerrehabilitering för patienter inom upptagningsområdet med avancerade behov.

6.4.1 Särskild satsning på rehabilitering, palliativ vård, aktiva överlämningar och seneffektsuppföljning – insatser 2025

För att stärka cancerrehabilitering och palliativ vård för barn och vuxna har RCC Väst beviljat 12 förbättringsprojekt inom cancerrehabilitering och 12 inom palliativ vård. Två av projekten syftar till att stärka seneffektsuppföljningen respektive öka tillgängligheten till psykosocialt stöd för unga cancerpatienter efter barncancer. Uppföljning av projekten sker kontinuerligt och rapporteras även till Socialstyrelsen. Samtliga projekt finns redovisade i gemensamt nationellt dokument på [RCC:s webbplats](#).

6.5 Min vårdplan

RCC Väst stöttar löpande de sjukvårdsregionala verksamheterna vid införande av Min vårdplan. Utbildnings- och stödsatser genomförs utifrån behov i verksamheterna. Två större workshops har genomförts i samverkan med SCCC och onkologen på SU, 13 utbildningsaktiviteter genomförda under första halvåret 2025, fler är planerade.

RCC Väst har genomfört förändringar av regionalt, digitalt stöd- och utbildningsmaterial för Min vårdplan. Ambitionen är att minska regional variation och bidra till nationell samstämmighet.

6.6 Barncancerområdet

RCC Väst har under våren fortsatt stödja implementering av de nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering, långtidsuppföljning och palliativ vård. Arbetet med långtidsuppföljning/transition och palliativ vård har förstärkts genom nya processledarroller och tvärprofessionella team.

Inom cancerrehabilitering för barn och ungdomar har nulägesanalyser genomförts i syfte att jämföra nuvarande arbetssätt med rekommendationerna i vårdprogrammet. En särskild arbetsgrupp kartlägger tillgången till psykosocialt stöd för barncancerpatienter och deras familjer. Arbetet kommer utgöra grund för lokala och regionala förbättringsarbeten samt vara en del av den nationella kartläggningen som ska presenteras under 2025.

En regional handlingsplan med 39 insatser för en stärkt cancervård för barn och unga inom cancervården i västra sjukvårdsregionen är under genomförande. Den årliga PREM-enkäten har genomförts i syfte att fånga

barn och föräldrars upplevelser av vården. Revidering av Barnonkologi-handboken intensifierades under våren och under senare delen av hösten väntas även en ny nationell version vara klar. Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp samordnar arbetet och bidrar till samverkan mellan vårdgivare.

6.7 Kunskapsutveckling samt uppföljning av cancervården

Den lagstadgade inrapporteringen till Cancerregistret vid Socialstyrelsen ligger till grund för rapporteringen till kvalitetsregistren inom cancerområdet.

RCC Väst ansvarar för hanteringen av regionala data som årligen rapporteras in till Cancerregistret och kontinuerligt till respektive nationellt kvalitetsregister.

RCC Väst är stödjande RCC för åtta av de trettiofem nationella kvalitetsregistren inom Nationellt programområde cancer. För alla dessa tillhandahåller RCC

Väst återkoppling av data till olika målgrupper öppet på cancercentrum.se och innanför inloggning på INCA, beroende på innehåll. RCC Väst hanterar också, efter särskild prövning, utlämnande av data till forskning från dessa datakällor. Flera av registren tar del av och redovisar patientrapporterade mått.

RCC Väst stödjer regionernas arbete med rapportering till läkemedelsregistret genom att möjliggöra automatiserad överföring från journalsystem till kvalitetsregister.

RCC Väst stödjer implementeringen av nya och reviderade vårdprogram genom återkommande regionala vårdprocess- och omvårdnadsmöten, dialogturnéer, regiondagar samt utbildningsinsatser med berörda professioner. Regional anpassning till nationella vårdprogram regleras i regionala medicinska riktlinjer.

RCC väst samverkar med många olika aktörer för att erbjuda kompetenshöjande insatser för medarbetare inom vården. Ett exempel är cytostatikakörkortet som riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor som hanterar cytostatika. Under våren 2025 har tre utbildningstillfällen genomförts med ett sextiofem deltagare.

RCC Väst samverkar efter upphandling med Högskolan i Borås och kommer i september starta den årliga uppdragsutbildningen Kontaktsjuksköterskan i cancervården, 7,5 hp. Utbildningen har givits sedan 2014 i samverkan med olika lärosäten. RCC Väst samverkar med Göteborgs universitet kring genomförandet av forskarutbildning, den kliniska forskarskolan vid



Sahlgrenska akademin, 30 hp. Utbildningen har givits sedan 2011 och är riktad till forskarstuderade som är kliniskt verksamma inom Västra sjukvårdsregionen.

Ett flertal forskningsprojekt pågår i samverkan med klinik sedan tidigare. Ett exempel är PPMC Lungcancer som är ett forskningsprojekt där sjukvårdens befintliga infrastruktur används för att bygga upp en regional biobank med prospektivt insamlat material vilket ska användas för forskning inom precisionsmedicin för lungcancer. Ett annat är DIBH-App där patienter får träna på rätt andningsteknik inför andningsadapterad strålbehandling via ett digitalt verktyg i hemmet.



Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård.
www.cancercentrum.se